7 Esiti di salute e performance del Servizio Sanitario Nazionale

di Vittoria Ardito, Oriana Ciani, Carlo Federici, Alessandro Furnari, Laura Giudice, Agnese Palvarini e Rosanna Tarricone[1]

7.1 Introduzione

Il presente capitolo del Rapporto OASI, da alcuni anni ormai, è dedicato ad analizzare quali siano gli esiti di salute prodotti nel SSN italiano e quale sia la performance complessiva del SSN nello svolgimento dei suoi compiti precipui.

Lo «stato di salute» del nostro Paese può essere valutato in ottica comparativa a livello internazionale, sulla base di confronti con Paesi vicini e simili al nostro, ma anche in ottica comparativa a livello nazionale, sulla base di confronti interregionali, che mirano a rappresentare eventuali divari e potenziali situazioni di diseguaglianza sul territorio nazionale. L'universalità e l'equità del diritto alla salute rappresentano principi fondamentali del SSN sin dalla sua istituzione, nella consolidata prospettiva che sistemi iniqui costituirebbero una soluzione non efficiente (Berkowitz *et al.*, 2020). In questo quadro, la tutela della salute passa dal combinato disposto di diversi fattori che sostengono configurazione ed erogazione di servizi e, più in generale, il funzionamento del sistema sanitario. Valutare la *performance* del SSN implica avere consapevolezza della sua governance multi-livello e della sua multidimensionalità nativa, nel tentativo di stabilire la coerenza interna tra risorse impiegate e risultati conseguiti. A livello di sistema Paese, il monitoraggio dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) rappresenta un tentativo di valutazione multidimensionale, punto di riferimento per la verifica degli adempimenti richiesti alle regioni circa le prestazioni e i servizi che il SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini. A questo riguardo, il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) è lo stru-

[1] Sebbene il capitolo sia frutto del lavoro congiunto degli autori, il paragrafo 7.1 è attribuibile a Oriana Ciani e Alessandro Furnari, il paragrafo 7.2 a Vittoria Ardito, Oriana Ciani e Agnese Palvarini, il paragrafo 7.3 a Vittoria Ardito, Laura Giudice e Agnese Palvarini, il paragrafo 7.4 a Carlo Federici, Alessandro Furnari, Laura Giudice, il paragrafo 7.5 a tutti gli autori. Le autrici e gli autori ringraziano la Dottoressa Camilla Ostuni che ha collaborato al presente lavoro di ricerca, contribuendo alla raccolta dei dati e delle informazioni.

mento idealmente deputato a incorporare tale monitoraggio e raccordarlo con le scelte allocative di sistema, quantomeno con riferimento alle quote premiali degli SSR. Nella prassi, le metriche che lo compongono tendono "a cascata" a essere incorporate nei processi di responsabilizzazione di Regioni e Aziende, con l'indubbio vantaggio di offrire una base comparativa comune che tuttavia rischia di produrre disallineamenti tra le dimensioni di valutazione e gli oggetti di lavoro contemporanei del nostro sistema.

Il presente capitolo propone una duplice rappresentazione: da un lato, fotografa lo stato di salute della popolazione; dall'altro, riflette sui contenuti di responsabilizzazione che il sistema si dà e degli effetti che questi producono sui processi di prioritizzazione regionali ed aziendali. In particolare, esso è così strutturato: il paragrafo 7.2 è dedicato alla prospettiva internazionale sugli esiti di salute, con un focus su aspettativa di vita (7.2.1) e mortalità (paragrafo 7.2.2); il paragrafo 7.3 approfondisce il contesto nazionale, con dettagli relativi a esiti di salute (es. speranza di vita) e prevalenza della cronicità (paragrafo 7.3.1) e rilevazioni puntuali su determinanti non mediche della salute e aderenza terapeutica (paragrafo 7.3.2). A seguire, il paragrafo 7.4 propone un approfondimento dedicato ai sistemi di programmazione, monitoraggio e valutazione delle performance del SSN, esplorando le diverse accezioni che questi possono avere (7.4.1) e le ricadute che producono sugli obiettivi delle direzioni generali aziendali (7.4.2). Il capitolo si conclude con una sintesi delle evidenze riportate e conseguenti riflessioni per la programmazione del SSN.

7.2 Lo stato di salute della popolazione: una prospettiva internazionale

Il presente paragrafo propone alcune considerazioni generali sullo stato di salute della popolazione, in ottica di comparazione internazionale[2], rappresentando un aggiornamento rispetto alla precedente edizione del Rapporto (Ardito *et al.*, 2024).

Le fonti informative considerate sono i principali osservatori e database di monitoraggio presenti a livello internazionale:

- OECD (*OECD Health Statistics* 2025), con riferimento all'anno 2023 o all'ultimo anno disponibile;
- WHO (*Global Health Observatory database*), con riferimento al 2023 o all'ultimo anno disponibile;

[2] Sono stati considerati i principali Paesi europei (Grecia, Portogallo, Irlanda, Norvegia, Repubblica Slovacca, Lussemburgo, Italia, Regno Unito, Danimarca, Spagna, Francia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Finlandia, Germania, Belgio, Olanda, Svezia, Svizzera), a cui sono stati aggiunti USA, Canada, Giappone e i Paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina).

- GBD (*Global Burden of Disease*), con riferimento al 2022 o all'ultimo anno disponibile.

L'analisi si concentra su alcuni indicatori rilevanti per la definizione delle priorità di policy di salute pubblica. In particolare, sono qui considerati l'aspettativa di vita generale e in buona salute, oltre ai tassi di mortalità.

7.2.1 Aspettativa di vita

La prima dimensione presa in esame riguarda la speranza di vita nei 28 Paesi considerati tra il 2000 e il 2023, con particolare riferimento all'aspettativa di vita alla nascita (Tabella 7.1).

Tabella 7.1 **Aspettativa di vita alla nascita (2000, 2010, 2023)**

Paesi	2000	2010	2023	Differenza 2000-2010	Differenza 2010-2023	Differenza 2000-2023
Austria	78,3	80,7	81,9	2,4	1,2	3,6
Belgio	77,9	80,3	82,5	2,4	2,2	4,6
Brasile	69,6	73,8	75,8	4,2	2,0	6,2
Canada	79,3	81,4	81,7	2,1	0,3	2,4
Cina	72,3	75,7	78,0	3,4	2,3	5,7
Danimarca	76,9	79,3	81,8	2,4	2,5	4,9
Finlandia	77,8	80,2	81,6	2,4	1,4	3,8
Francia	79,2	81,8	83,0	2,6	1,2	3,8
Germania	78,3	80,5	81,1	2,2	0,6	2,8
Giappone	81,2	82,9	84,1	1,7	1,2	2,9
Grecia	78,6	80,6	81,8	2,0	1,2	3,2
India	62,7	67,2	72,0	4,5	4,8	9,3
Irlanda	76,6	80,8	82,9	4,2	2,1	6,3
Italia	79,9	82,2	83,5	2,3	1,3	3,6
Lussemburgo	78,0	80,8	83,4	2,8	2,6	5,4
Norvegia	78,8	81,2	83,1	2,4	1,9	4,3
Olanda	78,2	81,0	81,9	2,8	0,9	3,7
Polonia	73,8	76,4	78,4	2,6	2,0	4,6
Portogallo	76,8	80,1	82,5	3,3	2,4	5,7
Regno Unito	77,8	80,4	81,0	2,6	0,6	3,2
Repubblica Ceca	75,1	77,7	79,9	2,6	2,2	4,8
Repubblica Slovacca	73,3	75,6	78,2	2,3	2,6	4,9
Russia	65,5	68,8	73,3	3,3	4,5	7,8
Spagna	79,3	82,4	84,0	3,1	1,6	4,7
Svezia	79,8	81,6	83,4	1,8	1,8	3,6
Svizzera	80,0	82,7	84,3	2,7	1,6	4,3
U.S.A.	76,8	78,7	78,4	1,9	-0,3	1,6
Ungheria	71,9	74,7	76,7	2,8	2,0	4,8

Fonte: Elaborazioni su dati OECD 2025.

All'interno dei paesi in esame si osserva, in media, un aumento di circa quattro anni e mezzo (+4,5 anni) nell'aspettativa di vita tra il 2000 e il 2023. I primi tre paesi in base a tale indicatore sono rispettivamente la Svizzera (84,3), il Giappone (84,1) e la Spagna (84,0), con l'Italia che si trova al quarto posto con un'aspettativa di vita pari a 83,5 anni. Si nota che la gran parte di questo trend crescente si registra nella prima parte del periodo (2000-2010), mentre tra 2010 e 2023 si denota un graduale appiattimento delle differenze su base temporale.

In aggiunta a questa misura che esprime la «quantità» di vita attesa, l'aspettativa di vita in buona salute (*healthy life expectancy*) offre un'indicazione sulla sua «qualità». L'aspettativa di vita in buona salute permette infatti di monitorare la salute in quanto fattore produttivo, valutare l'occupabilità dei lavoratori anziani e controllare i progressi compiuti in termini di accessibilità, qualità e sostenibilità dell'assistenza sanitaria. Non a caso, questo indicatore figura tra i principali indicatori strutturali europei e la sua importanza è stata riconosciuta nella Strategia di Lisbona (Commissione Europea, 2017). Tale indicatore fornisce un'idea della quantità media di tempo. Nel momento in cui si scrive (agosto 2025), i dati risultano aggiornati al 2021. La Tabella 7.2 offre una panoramica sull'aspettativa di vita in buona salute in uno scenario inevitabilmente influenzato dallo scenario pandemico. Dal punto di vista di tale indicatore, l'Italia risulta al settimo posto per aspettativa di vita in buona salute (70,6), preceduta da Giappone (73,4), Norvegia (71,2), Lussemburgo (71,2), Svezia (71,1), Svizzera (71,1) e Spagna (71,1). I dati del 2021 mostrano anche come lo scarto tra aspettativa di vita totale e aspettativa di vita in buona salute alla nascita in Italia sia pari a 12,9 anni, a fronte di 3,6 anni in Canada e 14,7 anni in Brasile. Tale indicatore fornisce un'idea della quantità media di tempo vissuto con una patologia invalidante nell'arco della vita. Durante questi anni il cittadino sarà verosimilmente più a contatto con il sistema sanitario e di assistenza sociale del proprio Paese, beneficiando di servizi e assorbendo risorse. Queste cifre sono di estrema importanza nel disegno dei sistemi di tutela della salute, in considerazione della loro potenziale rilevanza nel consumo di servizi sanitari e nell'evoluzione dei bisogni di salute di una popolazione.

7.2.2 Dati di mortalità a confronto

Le considerazioni sull'aspettativa di vita possono essere integrate dall'analisi dei tassi di mortalità per cause di morte. Nonostante ci siano alcuni limiti riconosciuti nell'uso della mortalità come stimatore del bisogno (ad esempio, non restituisce informazioni sulla severità delle patologie, la sua evoluzione dipende da fattori che evolvono lentamente nel tempo e non sempre sono riconducibili all'azione degli enti preposti alla tutela della salute pubblica), i tassi

Tabella 7.2 **Aspettativa di vita in buona salute alla nascita e a 60 anni (2000 e 2021)**

Health life expectancy (HALE) at birth (years)				Health life expectancy (HALE) at age 60 (years)			
Paese	2000	Paese	2021	Paese	2000	Paese	2021
Giappone	71,1	Giappone	73,4	Giappone	18,8	Giappone	20,4
Svezia	69,3	Norvegia	71,2	Francia	17,4	Svizzera	19,0
Spagna	68,9	Lussemburgo	71,2	Svizzera	17,4	Spagna	18,9
Canada	68,5	Svezia	71,1	Spagna	17,4	Lussemburgo	18,8
Svizzera	68,4	Svizzera	71,1	Svezia	17,2	Svezia	18,7
Italia	68,4	Spagna	71,1	Canada	17,1	Norvegia	18,7
Olanda	68,1	Italia	70,6	Italia	17,0	Francia	18,6
Francia	68,0	Francia	70,1	Grecia	16,7	Canada	18,5
Lussemburgo	67,9	Danimarca	70,1	Lussemburgo	16,7	Italia	18,4
Norvegia	67,8	Olanda	70,0	Norvegia	16,6	Irlanda	18,3
Grecia	67,7	Irlanda	70,0	Austria	16,6	Portogallo	18,2
Austria	67,6	Finlandia	69,9	Germania	16,5	Finlandia	18,1
Germania	67,5	Canada	69,8	Olanda	16,5	Belgio	18,0
Regno Unito	67,3	Austria	69,8	Belgio	16,4	Danimarca	18,0
Belgio	67,2	Belgio	69,8	Regno Unito	16,3	Olanda	17,8
Finlandia	66,9	Portogallo	69,5	Finlandia	16,2	Austria	17,7
Danimarca	66,7	Germania	68,9	Portogallo	16,2	Regno Unito	17,5
Irlanda	66,3	Grecia	68,6	Danimarca	15,8	Germania	17,3
Portogallo	66,1	Regno Unito	68,6	U.S.A.	15,7	Grecia	17,3
Rep. Ceca	65,3	Cina	68,6	Irlanda	15,6	Cina	16,2
Polonia	64,2	Rep. Ceca	66,7	Brasile	14,4	U.S.A.	15,7
U.S.A.	63,9	Polonia	65,5	Rep. Ceca	14,4	Rep. Ceca	15,0
Rep. Slovacca	63,9	U.S.A.	65,3	Polonia	14,3	Polonia	14,8
Cina	63,1	Rep. Slovacca	64,9	Cina	14,0	Brasile	14,7
Ungheria	62,2	Ungheria	64,8	Rep. Slovacca	13,8	Rep. Slovacca	14,1
Brasile	60,9	Brasile	61,8	Ungheria	13,3	Ungheria	14,0
Russia	56,7	Russia	60,9	Russia	12,3	Russia	12,7
India	54,1	India	58,1	India	11,5	India	12,7

Fonte: Elaborazioni su dati WHO 2024.

di mortalità restano indicatori utili a livello macro per offrire un quadro dello stato di salute di una popolazione. Questo si riscontra anche in virtù della loro diffusione e comparabilità su dimensioni, come le sopracitate cause di morte, che l'aspettativa di vita non permette di rappresentare.

Un ulteriore aspetto rilevante è legato all'andamento dei tassi di mortalità per alcune cause specifiche, la cui riduzione è spesso identificata come obiet-

tivo strategico verso cui tendere nei più importanti documenti di programmazione sanitaria, sia internazionali (WHO) sia nazionali (es. Piano Sanitario Nazionale). Secondo il *Global Burden of Disease Study* (GBD), a livello globale, le malattie non trasmissibili sono la causa principale di *disability adjusted life years* (DALY), contribuendo sia alla componente di anni vita persi (YLL) sia a quella di anni di vita trascorsi con disabilità (YLD). Le malattie cardiovascolari e i tumori sono i primi tra i 22 gruppi di malattie e lesioni considerate nello studio. In particolare, l'analisi per indice sociodemografico indica che, per i contesti agiati, i DALY legati al cancro hanno superato i DALY legati alle malattie cardiovascolari, rendendo i tumori la principale causa del carico totale di malattia nel 2019 (Global Burden of Disease 2019 Cancer Collaboration).

A partire da queste considerazioni, la Tabella 7.3 mostra i tassi di mortalità standardizzati per 100.000 abitanti per specifiche cause di morte. In Italia (dati del 2022) la mortalità per malattie cardiovascolari (219,3 per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla rilevazione del 2020 pari a 231,9) è superiore a quella per tumori (196,3 per 100.000 abitanti, in riduzione rispetto al dato della precedente rilevazione del 2020 pari a 206,2). Nonostante la riduzione generalizzata registrata nella mortalità dovuta a malattie del sistema cardiocircolatorio nel corso degli ultimi due decenni in Italia, i tassi relativi al nostro Paese risultano ancora distanti da quelli registrati in Giappone (144,1, dato del 2021), Francia (145,1, dato del 2022), Lussemburgo (169,7, dato del 2023), o Danimarca (172,8, dato del 2022). A titolo esemplificativo, si consideri che in Italia nel 1990 il tasso di mortalità per questo tipo di patologie era pari a 469,3 per 100.000 abitanti, a cui corrispondeva una mortalità per neoplasie maligne pari a 264,7 per 100.000 abitanti. Già nel 2006 si registrava, invece, un significativo calo del tasso di mortalità per malattie cardiovascolari (292,6 per 100.000 abitanti; -37,7%) a fronte di una riduzione più contenuta registrata nella mortalità per cause tumorali (226,4 per 100.000 abitanti; -22,6%). Oggi l'Italia si colloca al quattordicesimo posto nel campione analizzato per mortalità dovuta a malattie del sistema cardiocircolatorio (stabile rispetto alla posizione occupata nella precedente edizione del Rapporto), con un dato di mortalità di 219,3 decessi ogni 100.000 abitanti rispetto alla media di 252,9 decessi ogni 100.000 abitanti del campione analizzato.

Entrambe le aree di patologia rientrano tra le cosiddette malattie non trasmissibili (*non communicable diseases – NCDs*), su cui da tempo è posta l'attenzione dei responsabili di sanità pubblica a livello internazionale, dato che a queste si deve oltre il 71% della mortalità osservata e circa 15 milioni di morti premature all'anno nella fascia di età tra 30 e 69 anni (WHO, 2018). Rispetto alla mortalità osservata, nei Paesi ad alto reddito la percentuale di morti dovute a NCDs arriva a rappresentare circa il 90% dei decessi (Figura 7.1). Fino al

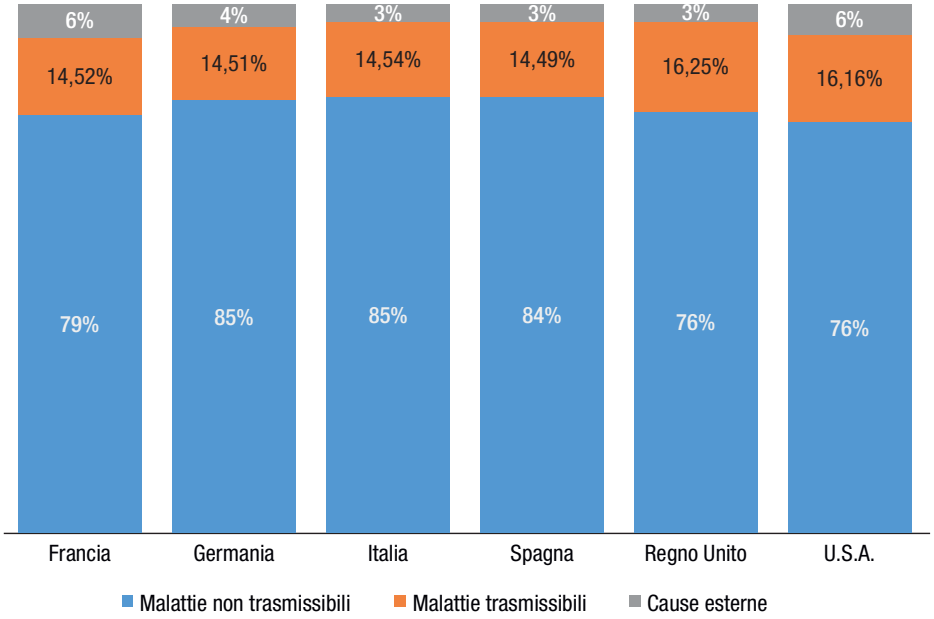
Tabella 7.3 **Mortalità per 100.000 abitanti per causa di morte – tasso standardizzato* (2023 o ultimo anno disponibile)**

Paese	Malattie del sistema circolatorio	Tumori	Malattie dell'apparato respiratorio	Cause esterne di mortalità	Malattie dell'apparato digerente	Sintomi, segni, cause indefinite	Malattie del sistema nervoso	Disturbi mentali e del comportamento	Malattie dell'apparato endocrino	Altro	Tutte le cause	Anno di riferimento
Austria	260,7	191,7	46	50,6	29	28,3	31,2	35,2	40,1	37,1	772,3	2023
Belgio	178,7	196,9	63	53,8	35	57,2	35,7	32,2	17,4	44,7	784,8	2021
Brasile	326,9	175,1	127,8	83,3	54	77,1	47,5	13	79,9	122,7	1412,6	2021
Canada	176,3	192,8	57,2	55,5	34,3	42,8	34,9	63,6	26	43,5	772,1	2022
Danimarca	172,8	225,9	88,6	36,4	34,1	78,5	45,2	57,2	28,7	53,4	843,4	2022
Finlandia	257,5	180,8	25,1	50,8	36,7	10,7	153,1	43,8	13,8	15,1	844,1	2022
Francia	145,1	200,5	47,1	53,4	30,7	79,4	40,2	26,8	26,4	41,0	732,5	2022
Germania	282,4	213,2	52,4	39	38,2	32,8	30,2	49,5	31,2	48,3	850	2020
Giappone	144,1	179,3	65,8	36,7	24,8	64,5	22,4	9,1	10,1	35,8	599,8	2021
Grecia	264,5	200,4	75	39,2	23,4	47	26,4	20,4	20,5	56,9	873,1	2022
Irlanda	221,3	220,3	86,5	34,4	29,7	6,6	39,4	48	21,1	40,7	784,6	2022
Italia	219,3	196,3	50,1	32,1	26	31	34,4	26,7	34,7	47,6	750,7	2022
Lussemburgo	169,7	167,5	63	38,1	28,7	29,9	34,4	42,8	21,8	41,0	651,6	2023
Norvegia	202,9	193,8	73,5	49,7	24				23,3		767,4	2022
Olanda	177,5	220,3	65,7	55,4	25,7	59,7	45,3	67,3	17,9	53,8	803	2023
Polonia	401,8	255,4	74,4	52,4	50,8	106,1	20,1	14,8	29	31,2	1111	2022
Portogallo	197,4	195,5	73,8	42,2	35,6	48,2	28,4	39,5	34,3	56,5	800	2022
Regno Unito	196,9	221,6	78,4	38,3	44,1	22,2	54,7	57,5	15,3	36,5	860,9	2021
Repubblica Ceca	372,1	219,3	70,6	46,3	43,3	28,8	33,9	16,1	47,5	44,0	936,3	2023
Repubblica Slovacca	491,4	237,5	87,7	44,3	53,3	16,2	16,5	1,8	12,4	59,1	1030,6	2023
Russia	633,8	208,4	42,6	93,2	68,2	103,4	80,1	15	32	50,9	1327,8	2019
Spagna	170,6	187,4	68,5	30,7	35,2	14,9	38,6	30,3	22,8	52,1	662,8	2023
Svezia	203,1	179,7	48	43,8	25,6	29	47,8	47	24,1	45,4	708,9	2023
Svizzera	174,8	161,8	41,5	40,4	25,3	42,3	33,5	50,5	16,6	37,9	636,2	2023
U.S.A.	281,8	183,4	79,1	93,1	39,4	15	82,7	43,7	52,1	62,1	988,8	2022
Ungheria	579.7	282.1	70.3	49.9	56.1	3.8	20.4	43	33	32,0	1187,1	2023
Media	252,9	200,2	66,1	49,3	35,8	44,7	44,0	35,8	28,2	47,6	865,1	

Note: Il numero di decessi in base a genere e cause è estratto dal WHO Mortality Database. L'età rappresenta il criterio di standardizzazione, calcolato dall'OECD Secretariat utilizzando la distribuzione per età della popolazione 2010 dei Paesi OECD. Le cause di morte seguono la classificazione ICD-10 (International Classification of Diseases 10). Non sono presenti dati relativi a India e Cina.

Fonte: Elaborazioni su dati OECD 2025.

Figura 7.1 **Distribuzione percentuale delle cause di morte sul totale dei decessi per macro-categoria, principali Paesi (2021)**



Fonte: Elaborazioni su dati del Global Burden of Disease Database.

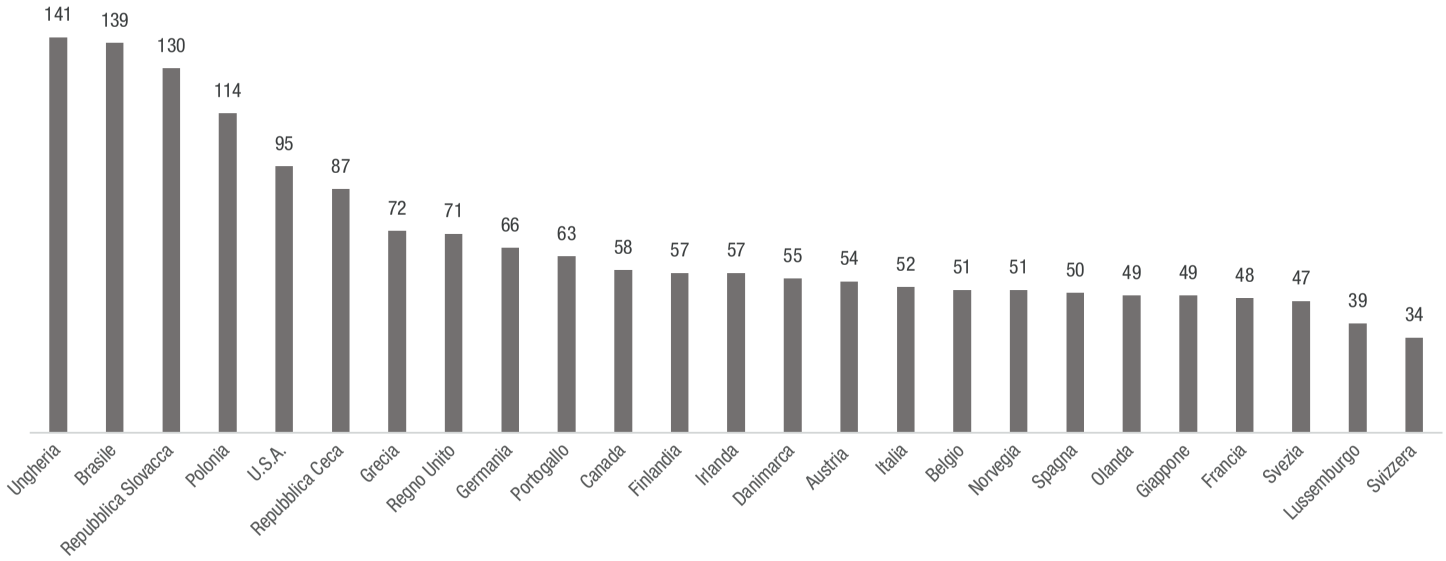
2019, la percentuale delle cause di morte (trasmissibili, non trasmissibili e cause esterne) era rimasta pressoché invariata per i paesi considerati rispetto agli ultimi anni (88% Italia, 92% Spagna e Germania, 90% USA, 89% Regno Unito, 87% Francia per le non trasmissibili). Con le rilevazioni del 2021, si nota invece un peso percentuale più alto delle malattie trasmissibili, presumibilmente riconducibile alla pandemia di COVID-19 (14,49% per la Spagna, 14,51% per la Germania, 14,52% per la Francia, 14,54% per l'Italia, 16,16% per gli USA e 16,25% per il Regno Unito).

Con riferimento ai 15 milioni di morti premature annue[3], nel mondo l'80% è dovuto a malattie cardiovascolari (35%), cancro (28%), malattie respiratorie (12%) e diabete (5%). In tutti i Paesi, il dato è maggiore per gli uomini rispetto alle donne e, tra il 2000 e il 2016, si è assistito a un trend decrescente della mortalità prematura dovuta a NCDs nei principali Paesi del mondo, soprattutto grazie agli investimenti in prevenzione nelle regioni ad alto reddito (Boscolo *et al.*, 2017).

A integrazione di quanto appena evidenziato, la Figura 7.2 riporta un altro

[3] Per morti premature si fa riferimento ai decessi tra i 30 e i 70 anni di età per malattie cardiovascolari, cancro, diabete e malattie respiratorie croniche. Tale indicatore è calcolato sulla base dei tassi di mortalità specifici per età per le quattro cause di morte considerate (https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/3411)

Figura 7.2 **Mortalità riconducibile ai servizi sanitari (*amenable mortality*), tasso standardizzato di morti premature (under 75) ogni 100.000 abitanti (2023 o ultimo anno disponibile)**



Note: I dati relativi a Austria, Lussemburgo, Olanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria fanno riferimento al 2023; quelli relativi a Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo e U.S.A. al 2022; quelli relativi a Brasile, Giappone e Regno Unito al 2021; quelli relativi a Belgio e Germania al 2020; quelli relativi alla Norvegia al 2016.

Fonte: Elaborazioni su dati OECD 2025.

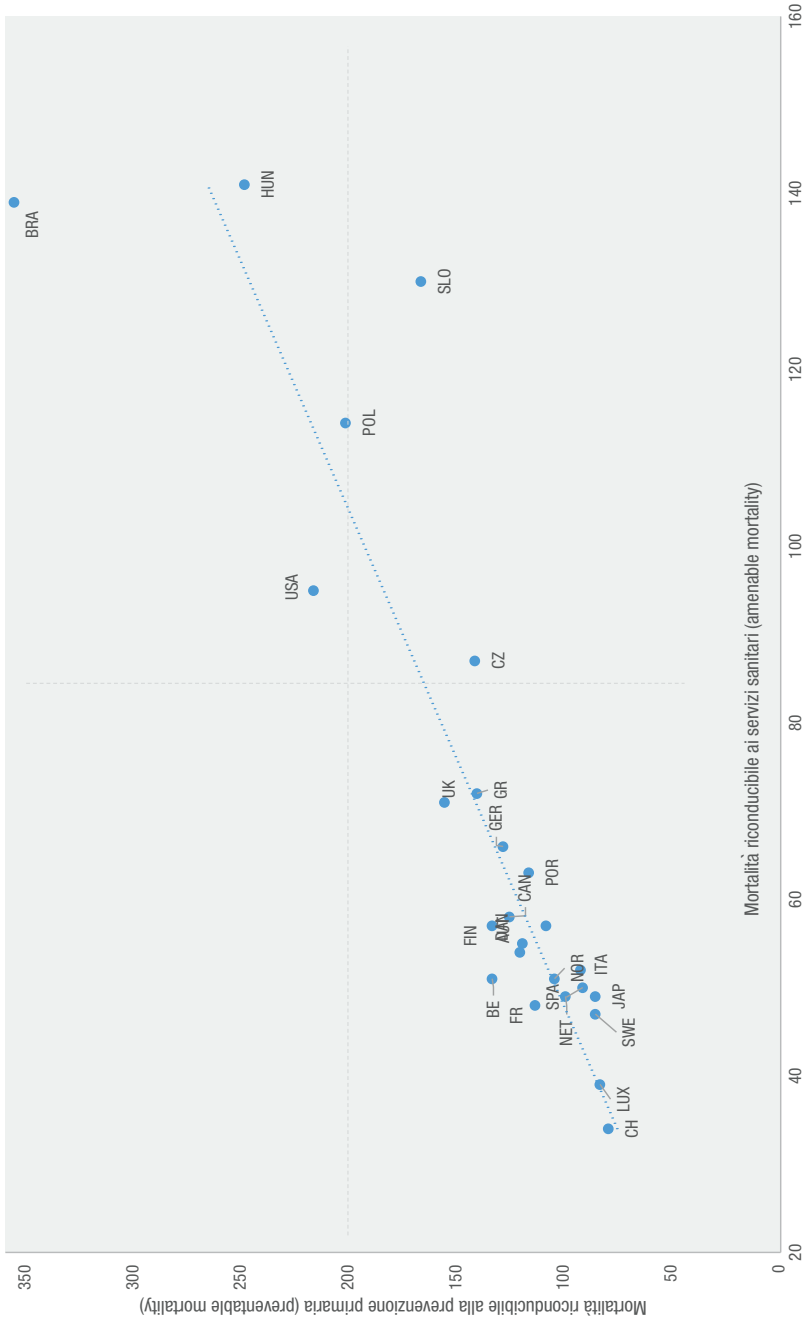
interessante indicatore legato alla mortalità, l'*amenable mortality*, utile a comprendere quanto questa possa essere imputabile a eventuali carenze dei sistemi sanitari in termini di efficacia e tempestività delle cure e degli interventi diagnostico-terapeutici di provata efficacia nel rispondere all'insorgere della causa primaria di morte dell'individuo. I dati riferiti al 2023 (o ultimo anno disponibile) restituiscono un quadro tutto sommato confortante per l'Italia (52 decessi ogni 100.000 abitanti under 75 a dati del 2022), con appena 9 Paesi con un valore dell'indicatore più contenuto, seppur di poco: Belgio e Norvegia, 51 per 100.000 abitanti; Spagna, 50; Francia, Giappone e Olanda, 49; Svezia, 47; Lussemburgo, 39; Svizzera, 34.

In aggiunta alla prospettiva di analisi appena illustrata e in modo complementare, la Figura 7.3 propone un confronto sulla mortalità evitabile, in particolare guardando all'incidenza della «*treatable (o amenable) mortality*» e della «*preventable mortality*». La prima è relativa ai decessi potenzialmente evitabili tramite sistemi sanitari in grado di operare in modo tempestivo ed efficace, compreso attraverso programmi di prevenzione secondaria volti a contenere a valle la fatalità delle malattie/patologie; la seconda riguarda i decessi potenzialmente evitabili tramite buone politiche di sanità pubblica e prevenzione primaria volte a ridurre a monte l'incidenza delle malattie. Il grafico mostra un trend lineare: nel quadrante in alto a destra figurano paesi con elevata mortalità lungo entrambe le dimensioni di analisi, come ad esempio, Brasile, Ungheria, Slovenia e Polonia; nel quadrante in basso a sinistra, invece, figurano Paesi come Svizzera, Lussemburgo, Svezia e Giappone che, evidenziando valori contenuti in entrambe le dimensioni di indagine, sono indicativi di sistemi sanitari in grado di intervenire efficacemente a monte e a valle, sia sulla prevenzione di primo e secondo livello, sia sul trattamento. In questo senso, il caso dell'Italia è piuttosto rassicurante, assumendo valori in linea con quelli degli altri Paesi simili per complessità dei sistemi sanitari e per struttura socio-economica.

7.3 Lo stato di salute della popolazione e le relative determinanti: il contesto nazionale

Il presente paragrafo propone una rappresentazione di alcune rilevanti misure di esito e di performance che mirano a inquadrare lo stato di salute della popolazione italiana e del suo SSN. In questo quadro, il paragrafo riporta il confronto interregionale di speranza di vita generale e in buona salute (par. 7.3.1), con l'aggiunta di un rinnovato approfondimento sulla prevalenza delle cronicità e sulla mortalità evitabile rispetto alla precedente edizione del capitolo (Ardito *et al.*, 2024). Si propone inoltre un approfondimento sui comportamenti individuali rilevanti ai fini della salute pubblica, con particolare riferimento ad alcuni determinanti non medici della salute, tra cui stili di vita e

Figura 7.3 **Confronto tra la mortalità riconducibile ai servizi sanitari (*amenable mortality*) e la mortalità riconducibile alla prevenzione primaria (*preventable mortality*) ogni 100.000 abitanti (tassi standardizzati)**



Fonte: Elaborazioni su dati OECD 2025.

aderenza terapeutica (par. 7.3.2). A tal fine, sono state considerate le seguenti fonti informative:

- ISTAT (*Sistema di nowcast per indicatori demografici*), con riferimento agli anni 2002-2023 o ultima rilevazione disponibile;
- BES (*Rapporto BES: Il benessere equo e sostenibile in Italia, 2023*), con riferimento agli anni 2023-2024;
- ISTAT (*Indagine su decessi e cause di morte*), con riferimento agli anni 1990-2023 o ultima rilevazione disponibile;
- ISTAT (*Indagine su stato di salute e comorbidità*), con riferimento agli anni 2002-2023 o ultima rilevazione disponibile;
- ISS (*Sistema di sorveglianza PASSI*), con riferimento all'anno 2023;
- AIFA (*Rapporto OsMed*), con riferimento all'anno 2023.

7.3.1 Speranza di vita e cronicità nel paese

La Tabella 7.4 mostra come la speranza di vita alla nascita tra il 2005 e il 2023 sia aumentata di +2,3 anni a livello nazionale, raggiungendo un valore di 83,0 anni. Le regioni che nel 2023 fanno registrare la più elevata speranza di vita nel Paese sono la P.A. di Trento, la P.A. di Bolzano e le Marche (rispettivamente 84,6, 84,2 e 83,9 anni), mentre i valori più modesti si osservano in Campania, Sicilia e Calabria (rispettivamente 81,3, 81,6 e 81,9 anni).

Anche con riferimento all'aspettativa di vita a 65 anni si registra un aumento generalizzato nel periodo in analisi e a livello nazionale si raggiunge un valore pari a 20,9 anni, con un incremento di +1,6 anni tra il 2005 e il 2023. Anche in questo caso, le regioni migliori nel 2023 sono la P.A. di Trento, la P.A. di Bolzano e le Marche (rispettivamente 22,2, 21,9 e 21,5 anni), mentre i valori più modesti si osservano in Campania, Sicilia e Calabria (rispettivamente 19,6, 20,2 e 20,6 anni).

Dopo aver analizzato la «quantità» di vita attesa, è interessante valutarne la «qualità» utilizzando come *proxy* la speranza di vita in buona salute. La Tabella 7.5 permette di osservare come la speranza di vita in buona salute alla nascita nel nostro Paese mostri una rilevante eterogeneità interregionale: si passa dai 53,4 anni della Calabria (in aumento rispetto ai dati del 2023) ai 69,7 della P.A. di Bolzano (pure in aumento rispetto ai dati del 2023), con un dato medio nazionale di 58,1 anni, in riduzione rispetto al dato 2023 (59,2 anni; -1,1 anni). In generale, il 2024 si contraddistingue per la riduzione di questo indicatore rispetto al valore della precedente rilevazione in 14 regioni, con i maggiori decrementi osservati in Valle d'Aosta (-4,5 anni), Marche (-2,3 anni), Campania (-2,2 anni) e Calabria (-2,0 anni). Se si considera la popolazione con oltre 65 anni di età, a fronte di una speranza di vita a 65 anni pari a 20,9 anni (rif. tabella precedente) circa la metà degli anni di vita (10 anni) trascorrono media-

Tabella 7.4 **Speranza di vita alla nascita e a 65 anni (2005, 2010, 2015, 2023)**

Regione	Speranza di vita alla nascita				Speranza di vita a 65 anni			
	2005	2010	2015	2023	2005	2010	2015	2023
Piemonte	80,6	81,6	82,1	83,0	19,2	20,0	20,2	20,8
Valle d'Aosta	79,7	81,3	81,1	83,2	19,1	19,8	19,9	21,2
Lombardia	80,9	82,0	82,8	83,8	19,4	20,1	20,5	21,4
PA Bolzano	81,3	82,7	83,2	84,2	19,9	20,8	21,2	21,9
PA Trento	81,4	82,5	83,5	84,6	20,0	20,7	21,2	22,2
Veneto	81,4	82,4	82,9	83,8	19,7	20,3	20,7	21,4
Friuli Venezia Giulia	80,6	81,8	82,4	83,4	19,4	20,1	20,5	21,2
Liguria	80,7	81,6	82,2	83,1	19,5	19,9	20,4	20,9
Emilia Romagna	81,3	82,3	82,9	83,6	19,8	20,4	20,7	21,3
Toscana	81,5	82,4	82,8	83,8	19,7	20,4	20,7	21,4
Umbria	81,1	82,3	82,9	83,7	19,5	20,5	20,8	21,4
Marche	82,1	82,8	83,0	83,9	20,3	20,8	20,9	21,5
Lazio	80,4	81,2	82,2	82,9	19,1	19,6	20,3	20,7
Abruzzo	81,1	81,6	82,3	83,0	19,5	20,1	20,5	20,8
Molise	80,6	81,6	82,1	82,3	19,3	20,3	20,4	20,6
Campania	79,1	80,0	80,5	81,3	18,1	18,8	19,0	19,6
Puglia	80,9	82,0	82,4	82,8	19,4	20,1	20,3	20,8
Basilicata	80,6	81,8	82,0	82,5	19,2	20,1	20,3	20,6
Calabria	80,5	81,5	81,9	81,9	19,1	20,0	20,1	20,2
Sicilia	80,0	80,8	81,3	81,6	18,6	19,3	19,6	19,9
Sardegna	80,6	81,8	82,2	82,5	19,6	20,5	20,7	20,9
Nord	81,0	82,1	82,7	83,6	19,5	20,2	20,5	21,3
Centro	81,1	81,9	82,6	83,4	19,5	20,1	20,5	21,1
Sud	80,1	81,1	81,6	82,1	18,8	19,6	19,8	20,3
ITALIA	**80,7**	**81,7**	**82,3**	**83,0**	**19,3**	**20,0**	**20,3**	**20,9**

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 2025.

mente senza limitazioni nelle attività quotidiane a livello nazionale, nonostante l'aumento dell'incidenza di malattie croniche legate all'invecchiamento e dei pazienti multi-cronici. La P.A. di Trento vanta la maggior aspettativa di vita senza limitazioni funzionali a 65 anni pari a 12,7 anni (in aumento di +0,2 anni rispetto al 2023), seguita da Friuli-Venezia Giulia (12,3 anni), Lombardia (12,2 anni) e la P.A. di Bolzano (12,1 anni). I valori più modesti si riscontrano invece in Sicilia (8,7 anni), Calabria (8,8 anni) e Umbria (9,0 anni). È interessante notare che tale indicatore si riduce rispetto al corrispettivo valore del 2023 in 11 regioni (Piemonte, P.A. di Bolzano, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania e Sicilia).

Mettendo in relazione le diverse variabili indagate finora, emerge come a livello nazionale il differenziale tra aspettativa di vita alla nascita generale e in buona salute sia pari a 24,9 anni, in aumento rispetto alla precedente edizione del Rapporto, quando era pari a 23,4 anni (Ardito *et al.*, 2024). Simil-

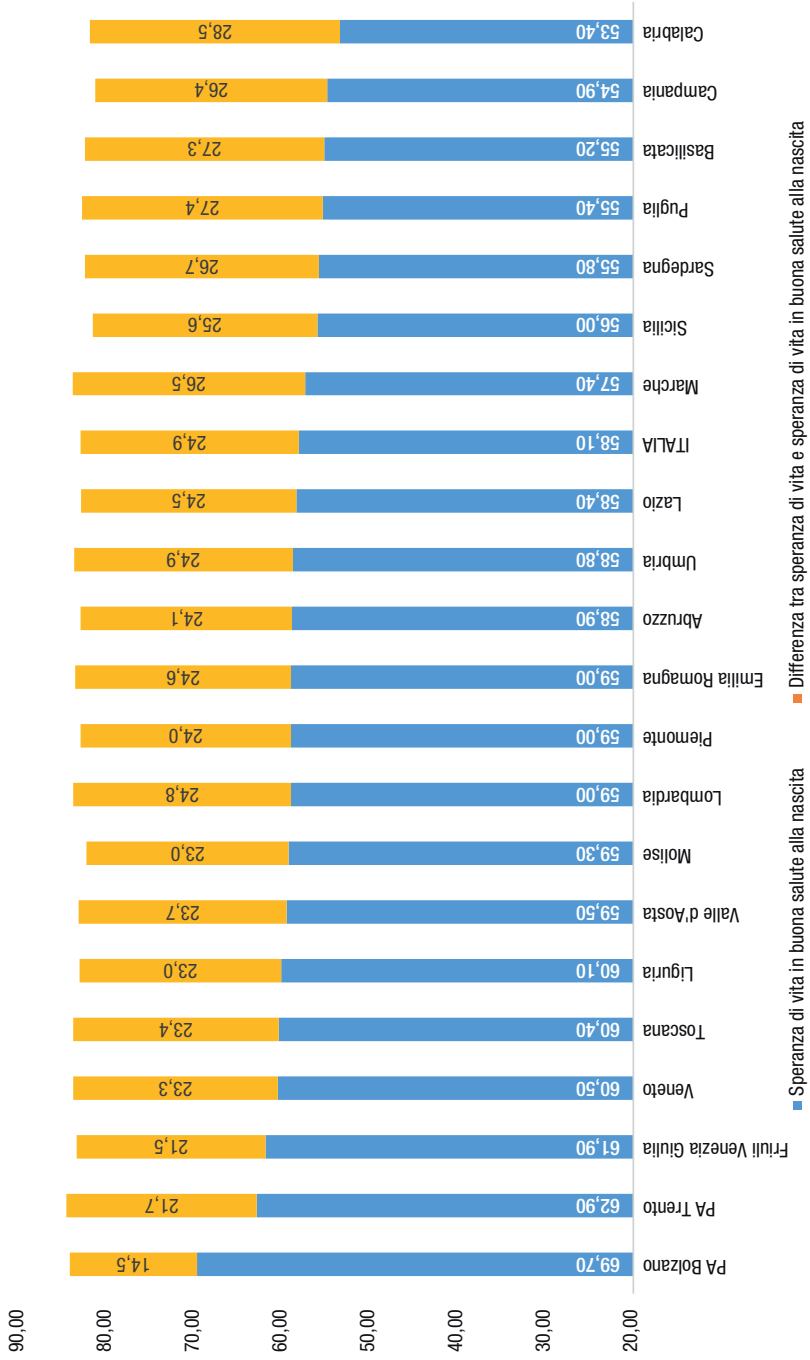
Tabella 7.5 **Speranza di vita in buona salute alla nascita e speranza di vita senza limitazioni nelle attività quotidiane a 65 anni (2024, dati provvisori)**

Regione	Speranza di vita in buona salute alla nascita	Speranza di vita senza limitazioni nelle attività quotidiane a 65 anni
Piemonte	59,0	11,4
Valle d'Aosta	59,5	11,6
Liguria	60,1	11,7
Lombardia	59,0	12,2
PA Bolzano	69,7	12,1
PA Trento	62,9	12,7
Veneto	60,5	11,2
Friuli Venezia Giulia	61,9	12,3
Emilia Romagna	59,0	10,3
Toscana	60,4	11,4
Umbria	58,8	9,0
Marche	57,4	10,5
Lazio	58,4	9,9
Abruzzo	58,9	9,4
Molise	59,3	11,3
Campania	54,9	9,3
Puglia	55,4	9,5
Basilicata	55,2	10,3
Calabria	53,4	8,8
Sicilia	56,0	8,7
Sardegna	55,8	9,8
Nord	59,7	11,6
Centro	58,9	10,4
Sud	55,3	9,4
ITALIA	**58,1**	**10,6**

Fonte: Rapporto BES 2025.

mente a quanto osservato nelle precedenti edizioni, a dati 2023-2024 le regioni che fanno registrare i valori più elevati di tale differenziale sono Calabria (28,5 anni), Puglia (27,4 anni) e Basilicata (27,3 anni). Viceversa, le regioni con il differenziale più contenuto sono P.A. di Bolzano (14,5 anni), Friuli-Venezia Giulia (21,5 anni) e la P.A. di Trento (21,7 anni) (Figura 7.4). Sebbene la stima della speranza di vita in buona salute alla nascita sia stata derivata da misure soggettive (sulla base del numero di individui che rispondono «*bene*» o «*molto bene*» alla domanda sulla salute percepita dell'indagine ISTAT «Aspetti della vita quotidiana»), va sottolineato come i valori dell'indicatore siano fortemente correlati alla mortalità, alla presenza di malattie croniche, alla disabilità e ai consumi sanitari, oltre a cogliere la variabilità degli effetti che i diversi eventi patologici producono sulla qualità della vita dei soggetti (Crialesi *et al.*, 2014).

Figura 7.4 **Differenziale in anni tra speranza di vita (2023) e speranza di vita in buona salute alla nascita (2024, dati provvisori), per regione**



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 2025 e Rapporto BES 2025.

Oltre alla speranza di vita, alla nascita e a 65 anni, un altro dato interessante per illustrare le condizioni di salute di un paese è relativo alla prevalenza delle cronicità. In continuità con l'edizione precedente del rapporto (Ardito *et al.*, 2024), si propone pertanto un approfondimento sulla diffusione delle malattie croniche in Italia, con uno spaccato per regioni, contesto abitativo di riferimento, e titolo di studio, aggiungendo inoltre una vista per classe di reddito.

In particolare, la Tabella 7.6 e la Tabella 7.7 classificano i malati cronici con 6 anni o più rispettivamente in base alla provenienza geografica ed al contesto abitativo di riferimento. Nello specifico, le tabelle riportano il dettaglio delle persone con almeno una o due malattie croniche, con malattie croniche in buona salute e delle persone che non soffrono di alcun tipo di cronicità. Si nota come nel Nord Italia ci siano più persone in buona salute (68,8 persone ogni 100

Tabella 7.6 **Malati cronici con 6 anni o più in base alla provenienza geografica, ogni 100 persone con le stesse caratteristiche (dati 2024)**

Malati cronici con 6 anni o più in base all'area geografica	Persone con almeno una malattia cronica	Persone con almeno due malattie croniche	Persone con malattie croniche in buona salute	Persone in buona salute
Abruzzo	45,8	25,2	43,1	66,8
Basilicata	41,6	23,8	34	62,6
Calabria	44,1	25	33,5	61,7
Campania	39,5	23,2	37,7	65,9
Emilia-Romagna	40,9	22	42	67,5
Friuli Venezia Giulia	40,2	21,8	44,4	70,5
Lazio	40,4	21,4	42,2	67,4
Liguria	44,7	22,7	44,4	67,3
Lombardia	41,7	20,5	46,6	68,5
Marche	43,3	23	41	65
Molise	41,6	25,2	39,9	67,2
Piemonte	42	20,3	43,2	67,2
P.A. Bolzano	31,4	12	63,8	83,7
P.A. Trento	39,2	17,5	53,6	73,1
Puglia	44	24,9	37	63,7
Sardegna	45,3	27,3	38,1	61,9
Sicilia	41,4	23,9	36,5	66
Toscana	40,7	21,5	44,1	68,3
Umbria	44,3	24,4	42,8	66,9
Valle d'Aosta	42,2	20,7	47,2	68,9
Veneto	40	19,8	46,1	69,8
Nord	41,1	20,5	45,4	68,8
Centro	41,2	21,9	42,7	67,4
Sud	42,1	24,2	37,3	64,7
Isole	42,4	24,7	37	65
ITALIA	**41,5**	**22,1**	**42,1**	**67,1**

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 2024.

Tabella 7.7 **Malati cronici con 6 anni o più in base al contesto abitativo di riferimento, ogni 100 persone con le stesse caratteristiche (dati 2024)**

Malati cronici con 6 anni o più in base al contesto abitativo di riferimento	Persone con almeno una malattia cronica	Persone con almeno due malattie croniche	Persone con malattie croniche in buona salute	Persone in buona salute
Fino a 2,000 ab,	42,5	22,5	40,9	64,9
2,001 - 10,000 ab,	42	21,7	42,8	66,7
10,001 - 50,000 ab,	42,1	22,6	41,7	67,3
50,001 ab, e più	40,6	22,4	42,4	68,2
Centro area metropolitana	40,3	21,7	40	67
Periferia area metropolitana	41,7	21,7	43,7	67,2

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 2024.

con le stesse caratteristiche, a fronte di una media nazionale di 67,1) o con malattie croniche in buona salute (45,4 persone ogni 100 con le stesse caratteristiche, a fronte di una media nazionale di 42,1), mentre nel Sud Italia e nelle isole vi è una maggiore concentrazione di persone con almeno due malattie croniche ogni 100 persone con le medesime caratteristiche (rispettivamente 24,2 e 24,7 persone, a fronte di una media nazionale di 22,1). In particolare, le regioni che riportano un miglior dato di persone in buona salute sono P.A. di Bolzano (83,7 persone), P.A. di Trento (73,1) e Friuli Venezia Giulia (70,5), mentre le regioni con il più alto tasso di persone con almeno due malattie croniche sono Sardegna (27,3), Molise (25,2) e Abruzzo (25,2). Guardando invece al contesto abitativo di riferimento, si conferma solo in parte il trend osservato nella precedente edizione del rapporto (Ardito *et al.*, 2024). La probabilità di essere in buona salute si attesta infatti su livelli praticamente equivalenti se si vive in periferia (67,2 persone ogni 100 con le stesse caratteristiche), o che nel centro di un'area metropolitana (67), mentre la probabilità di sviluppare almeno una malattia cronica è più elevata nelle zone periferiche (41,7 persone ogni 100 con le stesse caratteristiche) rispetto alle aree metropolitane centrali (40,3).

A seguire, la Tabella 7.8 categorizza i malati cronici con 6 anni o più in base al titolo di studio conseguito. È infatti ampiamente documentato in letteratura che livelli di istruzione più elevati sono tradizionalmente associati a migliori outcome di salute, compreso una minore prevalenza ed incidenza di malattie croniche (Choi *et al.*, 2011; Oude *et al.*, 2019, Raghupathi *et al.*, 2020). In questo caso, si riporta lo spaccato per tipologia specifica di cronicità: artrosi/artrite, broncopolmonite cronica, diabete, disturbi nervosi, ipertensione, allergie, malattie del cuore, osteoporosi, ulcera gastrica o duodenale. Similmente a quanto osservato nel precedente Rapporto, anche i dati di quest'anno mostrano che la probabilità di soffrire di patologie croniche è inversamente proporzionale rispetto al titolo di studio conseguito, fatta eccezione per le allergie che seguono

Tabella 7.8 **Malati cronici con 6 anni o più in base al titolo di studio conseguito, ogni 100 persone con le stesse caratteristiche (dati 2024)**

Malati cronici con 6 anni o più in base al titolo di studio	Artrosi, artrite	Bronchite cronica	Diabete	Disturbi nervosi	Ipertensione	Allergie	Malattie del cuore	Osteoporosi	Ulcera gastrica o duodenale
Licenza di scuola elementare, nessun titolo di studio	26,5	9,4	12	9,8	28,6	8,6	7,6	17,2	2,7
Licenza di scuola media	16,4	6,6	7,6	5,6	21,9	10,7	5,1	8	2,8
Diploma	12,7	5,7	4,5	4,2	16,8	13,1	3,4	6,3	2,1
Laurea e post-laurea	10,2	5,1	3	3,4	13,2	14,2	2,7	5	1,5
TOTALE	**16**	**6,6**	**6,6**	**5,5**	**19,9**	**11,7**	**4,5**	**8,6**	**2,3**

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 2024.

07_Oasi.indd 18 02/12/25 15:58

un trend opposto. In linea generale, si osservano infatti meno cronicità in chi ha conseguito un corso di laurea o post-laurea rispetto a chi ha conseguito un diploma di scuola superiore; meno cronicità in chi ha un titolo di diploma superiore rispetto a chi ha una licenza di scuola media; e così via.

Infine, la Tabella 7.9 classifica i malati cronici con 15 anni o più in base alle categorie professionali (tra cui, dirigente, quadro, lavoratore in proprio, operaio/a, studente, casalingo/a), ed allo stato occupazionale (ossia, occupato, in cerca di prima occupazione, disoccupato/a in cerca di nuova occupazione, ritirato/a dal lavoro, e in altra condizione). Ogni 100 persone con le medesime caratteristiche, 76,5 dirigenti, imprenditori, e liberi professionisti sono in buona salute, a fronte di 73,9 operai e apprendisti. Si nota un maggior numero di casalinghi/e con almeno una o almeno due malattie croniche (rispettivamente, 58,2 e 37,1 persone ogni 100 con le stesse caratteristiche), rispetto alle altre categorie professionali. Guardando invece allo stato occupazionale, i soggetti in cerca di prima occupazione sono la categoria con il maggior numero di persone in buona salute ogni 100 con le stesse caratteristiche (79,9), chiaramente anche per motivazioni anagrafiche. Confrontando i soggetti occupati con quelli disoccupati in cerca di nuova occupazione, nei primi si contano 74,2 persone in buona salute ogni 100 con le stesse caratteristiche, mentre nei secondi tale dato scende a 65,6 persone. Similmente, i primi contano un minor numero di

Tabella 7.9 **Malati cronici con 15 anni o più in base alle categorie professionali e allo stato occupazionale, ogni 100 persone con le stesse caratteristiche (dati 2024)**

Malati cronici con 15 anni o più in base all'area geografica	Persone con almeno una malattia cronica	Persone con almeno due malattie croniche	Persone con malattie croniche in buona salute	Persone in buona salute
Dirigenti, imprenditori, liberi professionisti	37	13	60	76,5
Direttivo, quadro, impiegato	34	12,1	56,7	74,9
Lavoratore in proprio, coadiuvante familiare, co.co.co.	37,2	14	47,8	69,5
Operaio, apprendista	31,3	11,2	53,6	73,9
Casalinga-o	58,2	37,1	31,9	50,6
Studente	16,3	4,1	74,8	88,9
Occupato	33,8	12,1	55,2	74,2
In cerca di prima occupazione	22,9	6,8	54	79,9
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione	36,7	15,6	42,1	65,6
Ritirato-a dal lavoro	77,9	53,5	31,8	40
In altra condizione	81,9	62,2	13,4	20,8
TOTALE	**46**	**24,9**	**41**	**63,3**

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 2024.

persone ogni 100 con le stesse caratteristiche con almeno una o due malattie croniche (rispettivamente, 33,8 e 12,1), rispetto ai secondi (rispettivamente, 36,7 e 15,6).

7.3.2 Stili di vita, aderenza terapeutica e determinanti non medici della salute

In questa sezione si propone un'analisi integrata di alcuni comportamenti individuali rilevanti ai fini della salute pubblica, con l'obiettivo di fornire un inquadramento dei principali determinanti non medici che influenzano lo stato di salute della popolazione. L'attenzione si concentra, da un lato, su quattro fattori di rischio a livello comportamentale – consumo di tabacco, assunzione di alcol fuori dai pasti, eccesso ponderale e sedentarietà – e, dall'altro, sull'aderenza terapeutica nelle patologie croniche, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come capacità dei pazienti di seguire in modo continuativo le terapie prescritte. I primi quattro indicatori rappresentano variabili chiave nei principali strumenti di programmazione nazionale e internazionale, quali il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020–2025 e le linee guida dell'OMS relative alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. La loro rilevanza è legata alla correlazione consolidata con esiti sfavorevoli di salute. L'aderenza terapeutica, pur essendo di natura differente, rappresenta anch'essa un fattore essenziale per il successo dei percorsi di cura soprattutto nelle condizioni croniche, con impatti rilevanti su esiti clinici e sostenibilità del sistema sanitario.

La Tabella 7.10 riporta i risultati del Sistema di sorveglianza PASSI, che monitora annualmente gli stili di vita e fattori di rischio comportamentali legati a malattie croniche non trasmissibili. I dati confermano la presenza di disuguaglianze territoriali sistemiche, con il Sud generalmente più esposto a molteplici fattori di rischio, mentre il Nord mostra criticità più specifiche. Il fumo è un fenomeno che riguarda il 23,8% della popolazione, con punte in Molise (31,4%), Campania (28,4%) e Umbria (28,2%). Le percentuali più contenute si registrano in regioni quali Veneto (19,7%), PA di Trento (20,5%), Toscana (20,5%) e PA di Bolzano (20,6%). La media del Sud (24,9%) è superiore a quella del Nord (22,8%). Il consumo di alcol fuori pasto presenta un chiaro differenziale Nord-Sud: è più diffuso nel Nord (17,2%), con valori elevati in PA Bolzano (24,9%) e Friuli Venezia Giulia (22,5%), mentre nel Sud (4,8%) rimane contenuto. L'eccesso ponderale interessa in media il 32,6% della popolazione, con livelli più alti nel Sud (36,7%), in particolare in Puglia (38,6%), Campania (37,4%) e Basilicata (37,0%). Le regioni del Nord e alcune del Centro mostrano invece valori più contenuti. Tra tutti gli indicatori, la sedentarietà evidenzia il divario più marcato: la media nel Sud (35,4%) è più che doppia rispetto al Nord (15,3%), con valori critici in Calabria (51,6%), Campania (41,8%) e Puglia (41,2%).

Tabella 7.10 **Fattori di rischio comportamentali relativi a fumo, alcol, sovrappeso e sedentarietà negli adulti (18-69 anni), ogni 100 abitanti con le stesse caratteristiche (2023-2024)**

Regioni	Fumatori	Consumo alcol fuori pasto	Sovrappeso	Sedentari
Piemonte	24,8	11,5	30,1	17,8
Valle d'Aosta	27,2	19,2	29,7	21,9
Lombardia	nd	nd	nd	nd
PA Bolzano	20,6	24,9	29,7	7,1
PA Trento	20,5	22,8	32,0	13,9
Veneto	19,7	17,8	30,1	14,5
Friuli Venezia Giulia	22,0	22,5	31,4	8,0
Liguria	24,2	6,4	29,8	23,2
Emilia Romagna	23,4	12,6	30,3	16,2
Toscana	20,5	9,0	28,3	24,3
Umbria	28,2	9,3	33,4	26,9
Marche	22,0	11,2	30,6	15,7
Lazio	25,3	8,2	31,5	26,1
Abruzzo	24,6	7,2	34,8	35,4
Molise	31,4	19,8	35,2	19,2
Campania	28,4	6,5	37,4	41,8
Puglia	24,1	6,2	38,6	41,2
Basilicata	23,4	6,6	37,0	34,9
Calabria	20,9	1,1	35,8	51,6
Sicilia	23,5	9,7	34,6	38,3
Sardegna	23,1	11,9	27,5	20,7
Nord	22,8	17,2	30,4	15,3
Centro	24,0	9,4	31,0	23,3
Sud	24,9	8,6	35,1	35,4
ITALIA	**23,8**	**10,4**	**32,6**	**27,2**

Note: Fumatori sono persone che hanno fumato 100 o più sigarette nella loro vita e che fumano tuttora (o che hanno smesso di fumare da meno di sei mesi). Il consumo alcol fuori pasto è relativo a persone che, negli ultimi 30 giorni, hanno consumato alcol esclusivamente o prevalentemente fuori pasto. Sovrappeso si riferisce a persone con un indice di massa corporea compreso tra 25,0 e 29,9 kg/m² calcolato dai valori autoriferiti di peso e altezza. Sedentari sono persone che non praticano alcuna attività fisica nel tempo libero e non lavorano, o svolgono un lavoro sedentario o uno che pur richiedendo uno sforzo fisico (moderato o pesante) non è regolare e continuativo nel tempo.
Regione Lombardia non ha partecipato all'indagine.

Fonte: Elaborazioni su dati del Sistema di sorveglianza PASSI 2023.

A seguire, la Tabella 7.11 mostra i dati raccolti dall'Agenzia Italiana del Farmaco in relazione all'aderenza terapeutica per classe di età e area geografica in nove tipologie di farmaci. Le terapie cardiovascolari – in particolare gli anticoagulanti (67,0%), seguiti dai farmaci per ipertensione (53,6%) e dagli antiaggreganti (54,2%) – presentano i livelli medi di persistenza più elevati, a fronte di performance molto più basse per farmaci destinati a patologie respiratorie e mentali. Con riferimento alle classi di età, la persistenza tende a decrescere

Tabella 7.11 **Persistenza a un anno al trattamento nella popolazione di età maggiore a 45 anni (2023)**

Classe età/ Area	Farmaci per ipertensione	Ipolipemizzanti	Antidiabetici	Anticoagulanti	Antiaggreganti	Antidepressivi	Farmaci per asma e BPCO	Farmaci per osteoporosi	Farmaci per disturbi genito-urinari
45-54 anni	55,6	49,2	50,5	55,9	55,8	37,0	4,6	54,8	44,6
55-64 anni	55,9	51,7	50,6	64,1	57,2	35,9	6,5	55,7	52,6
65-74 anni	54,3	52,1	47,8	70,8	56,0	34,6	8,4	52,6	54,9
75-84 anni	49,1	48,2	44,2	69,3	51,5	32,8	9,6	49,8	52,9
≥85 anni	43,3	45,4	39,5	62,3	48,8	28,1	8,0	44,3	51,7
TOTALE	**53,6**	**50,5**	**47,5**	**67,0**	**54,2**	**34,0**	**7,5**	**52,2**	**52,9**
Nord	53,9	52,5	49,9	64,5	56,3	34,4	8,5	57,8	54,1
Centro	54,3	51,3	47,4	71,7	56,2	34,6	7,8	54,0	53,3
Sud	52,0	47,6	45,2	67,4	51,0	32,9	6,5	45,6	51,2

Note: Persistenza al trattamento si riferisce alla quota di pazienti che dopo 12 mesi prosegue il piano terapeutico prescritto.

Fonte: Elaborazioni su dati del Rapporto OsMed 2023.

con l'avanzare dell'età in tutte le aree terapeutiche. Il calo è particolarmente evidente negli antidepressivi (da 37,0% a 28,1%) e per osteoporosi (da 54,8% a 44,3%). Anche per i trattamenti cronici cardiovascolari si osserva un declino progressivo oltre i 75 anni, pur mantenendo livelli più elevati rispetto ad altri ambiti. Per asma e BPCO si registra invece la tendenza opposta, con una lieve crescita all'aumentare dell'età (da 4,6% a 8,0%), che si attesa comunque su valori alquanto bassi. Solo gli anticoagulanti sembrano mantenere una buona tenuta fino agli 84 anni, prima di flettere sensibilmente nella classe ≥85. Le differenze territoriali risultano significative. Le regioni del Nord e del Centro mostrano la persistenza più elevata per la maggior parte delle categorie, in particolare per gli anticoagulanti (rispettivamente 64,5% e 71,7%), nelle terapie per osteoporosi (rispettivamente 57,8% e 54,0) e negli antiaggreganti (rispettivamente 56,3% e 56,3%). Il Sud mostra i livelli più bassi in quasi tutte le aree terapeutiche, con un distacco marcato nei farmaci per osteoporosi (-12,2 punti % rispetto al Nord) e negli ipolipemizzanti (-4,9 punti % rispetto al Nord). Anche la persistenza nei farmaci per asma e BPCO rimane molto contenuta in tutte le aree geografiche, ma con un minimo nel Sud (6,5%). La persistenza terapeutica resta quindi critica per diverse condizioni croniche, con una chiara penalizzazione per le fasce più anziane della popolazione e per alcune aree geografiche, in particolare il Sud.

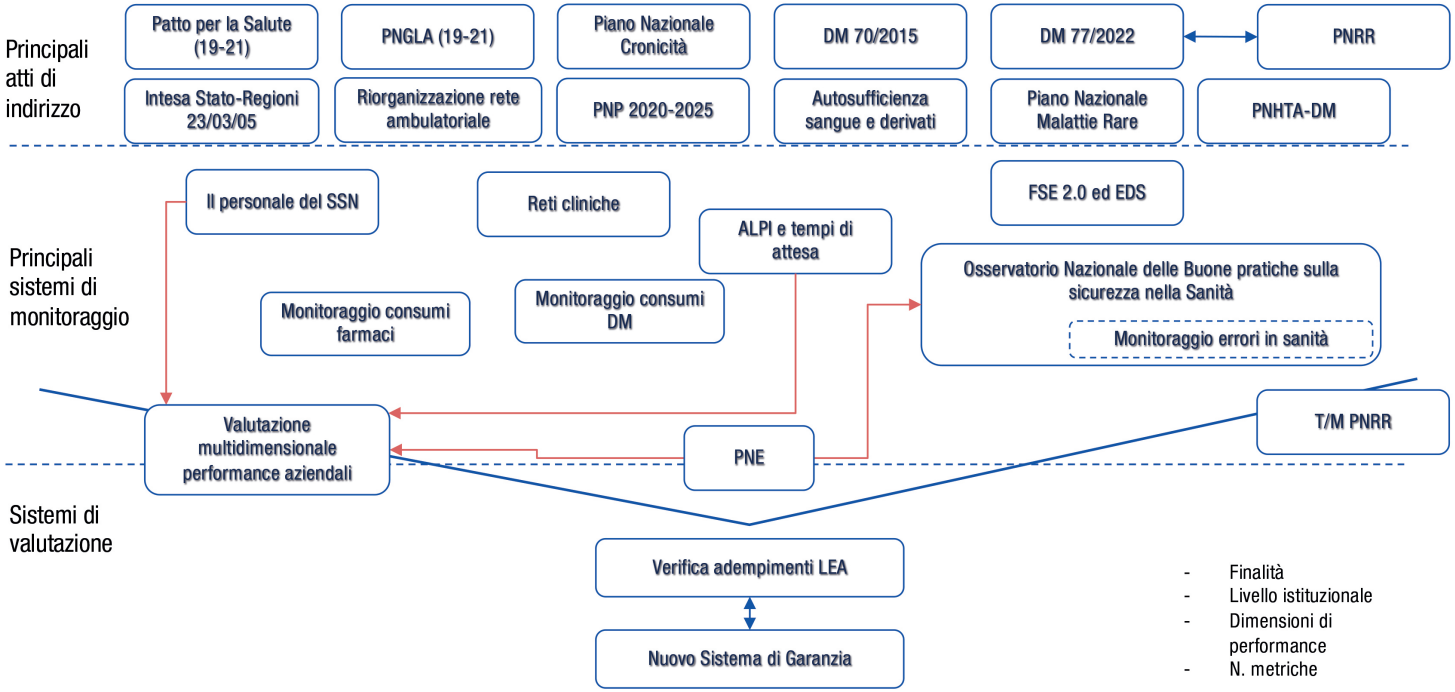
7.4 Le performance del SSN

7.4.1 Sistemi di monitoraggio e valutazione del SSN

Il monitoraggio del SSN nelle sue diverse articolazioni è un'attività centrale per cogliere e provare a rappresentarne la sostenibilità e l'efficacia nel perseguimento degli obiettivi di sistema. Si tratta di un complesso meccanismo che investe i diversi livelli istituzionali che caratterizzano il funzionamento del SSN e che richiede un reciproco adattamento tra priorità trasversali e capacità di approfondire specifici ambiti clinico-assistenziali. Un andamento complessivo soddisfacente può essere di fatto garantito soltanto bilanciando le due componenti. Nel farlo, è inevitabilmente necessario individuare delle priorità a monte, tipicamente soggettive, che investono tanto il livello tecnico-manageriale quanto il suo raccordo con il sistema di attese di una comunità e il livello politico che ne esprime la rappresentanza. Questi ultimi due elementi sono essenziali per cogliere l'importanza della ciclicità delle attività di programmazione e monitoraggio, con specificità chiaramente differenziate in base all'oggetto e al livello istituzionale di riferimento.

In questo contesto, la Figura 7.5 propone una schematizzazione dei principali strumenti che guidano e/o orientano il funzionamento complessivo del

Figura 7.5 **Programmazione sanitaria e sistemi di monitoraggio del SSN: quadro sinottico**



Note: l'acronimo PNGLA fa riferimento al Piano Nazionale Governo Liste di Attesa; PNP si riferisce al Piano Nazionale Prevenzione; PNHTA-DM fa riferimento al Piano Nazionale HTA per i dispositivi medici. Nei sistemi di monitoraggio non è stato esplicitamente inserito il riferimento alle metriche disegnate in ambito PNHTA-DM, in quanto non ancora operative.

Fonte: rielaborazione degli autori su fonti istituzionali

SSN nelle sue diverse articolazioni. Si tratta di un primo tentativo di catturare e isolare in un'unica rappresentazione i principali strumenti di programmazione e monitoraggio del sistema sanitario. Trattandosi di una forma di rappresentazione sintetica, non è stato possibile includere la totalità degli strumenti in dotazione al SSN. Tuttavia, è stata proposta una selezione di quelli ritenuti principali a livello nazionale e regionale, provando a offrire un quadro ampio e sufficientemente esaustivo di come il SSN cerchi di governare nella complessità. In particolare, ne sono state identificate tre famiglie:

- Atti di indirizzo: documenti programmatici che indicano le principali linee di indirizzo rispetto a specifici temi (es. configurazione della rete ospedaliera, rete territoriale, modalità di azione per rispondere ai fabbisogni di salute).
- Sistemi di monitoraggio: complesso di strumenti destinati a verificare l'andamento di specifici ambiti di attività attraverso la selezione di elementi prioritari che li caratterizzano e parametri che li descrivono.
- Sistemi di valutazione: complesso di strumenti e meccanismi attivati per definire e regolare il ciclo di verifica e ri-programmazione relativa al conseguimento di obiettivi da parte di organizzazioni e livelli istituzionali sovraordinati.

Le tre famiglie rappresentano tre momenti diversi nel ciclo della programmazione sanitaria. La prima mira a offrire la direzione di politica sanitaria del Paese; la seconda ha l'obiettivo di accompagnare la gestione dei diversi livelli istituzionali e sostenere il SSN nelle sue articolazioni attraverso la verifica della congruenza tra indirizzo e implementazione e/o attraverso lo sviluppo di metriche disegnate ad hoc; la terza offre sinteticamente elementi e criteri per osservare in modo critico il livello di conseguimento degli obiettivi istituzionali da parte del sistema sanitario. Ambito trasversale, il passaggio essenziale è dettato dalla fase di definizione della misurazione, tanto più cruciale quanto più rende operative le priorità nel rappresentare con misure oggettive il fenomeno che cerca di descrivere.

In sintesi, i diversi atti di indirizzo rappresentano la cornice all'interno della quale si inseriscono le scelte regionali e aziendali di configurazione dei servizi e di allocazione delle risorse, successivamente monitorati dal Comitato LEA in sede di valutazione degli adempimenti LEA. Qui per «verticali» si intendono i diversi ambiti disciplinari (prevenzione, assistenza ospedaliera, attività trasfusionale, …) che caratterizzano le attività del SSN. Essi sono dotati di appositi strumenti di monitoraggio e, laddove non espressamente previsto, richiedono l'individuazione di soggetti responsabili a livello regionale e, a cascata, aziendale. In questo senso, il Programma Nazionale Esiti (PNE) rappresenta un primo connettore di ambiti disciplinari, fungendo da punto di raccordo delle diverse prospettive di osservazione del SSN e dei SSR in termini di appropriatezza organizzativa e clinica ed esiti di salute generati. In seconda battuta, il Nuovo

Sistema di Garanzia (NSG, descritto nel capoverso successivo), cerca di rendere omogenee le diverse prospettive di cui si compone il SSN, offrendo una rappresentazione di sintesi dei livelli di risultato in termini di erogazione dei LEA. Il tentativo, non sempre pienamente raggiunto, è quello di rappresentare in ottica integrata ed esaustiva le diverse dimensioni che compongono gli ambiti di attività del SSN e di rapportarlo ai fabbisogni di salute espressi dalla popolazione. Nello schema proposto, è stato incluso inoltre anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che viene descritto nel perimetro degli attuali sistemi di monitoraggio. Come noto, si tratta di un programma di spesa che avrà impatto sulla gestione e le modalità di erogazione dei servizi. L'impatto e l'eventuale effetto «moltiplicatore» che potrà generare in termini di benefici sui meccanismi operativi aziendali e sui risultati regionali e nazionali sono tutti da costruire. Il fatto che il PNRR offra modesti spazi di approfondimento circa le metriche di monitoraggio dei risultati effettivamente conseguibili dal 2026 (termine fissato per la realizzazione degli interventi) in avanti rappresenta il motivo per cui viene posizionato solo tangenzialmente all'interno del framework qui proposto.

Come già trattato in precedenti versioni del Rapporto (Ardito *et al.*, 2021 e ss. edizioni), l'attività di monitoraggio dell'erogazione dei LEA rappresenta un importante e strutturato momento di verifica multidimensionale del profilo quali-quantitativo dei servizi erogati dal SSN e, implicitamente, della sua *performance*. Rappresenta un punto di riferimento per la verifica degli adempimenti richiesti alle Regioni circa le prestazioni e i servizi che il SSN è tenuto a fornire ai cittadini. In questo quadro, il NSG rappresenta lo strumento attraverso cui concretizzare il monitoraggio delle condizioni di qualità, appropriatezza e uniformità dei servizi erogati dal SSN. Recentemente aggiornato rispetto alla precedente versione (DM 12 marzo 2019), è costituito da un sistema descrittivo, di valutazione, monitoraggio e verifica dell'attività sanitaria erogata nelle diverse regioni. É disegnato allo scopo di integrare il lavoro del Comitato LEA in sede di verifica degli adempimenti dei SSR e monitorare l'erogazione dei LEA nelle regioni con riferimento a efficienza e appropriatezza organizzativa, efficacia ed appropriatezza clinica e sicurezza delle cure. Il NSG è organizzato per macro-livelli di monitoraggio: ai tradizionali tre già previsti dal precedente sistema di garanzia (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera) ne sono stati aggiunti due che provano a rappresentare in maniera più ampia il tema dell'evoluzione della domanda e della capacità del sistema di rispondere ai fabbisogni emergenti (elementi di contesto per la stima del bisogno sanitario, aspetti di equità sociale e monitoraggio PDTA). Per ciascuna macro-area sono individuate delle batterie di indicatori, per un totale di 88. In particolare:

- 16 per la prevenzione collettiva e sanità pubblica;
- 33 per l'assistenza distrettuale;

- 24 per l'assistenza ospedaliera;
- 4 indicatori di contesto per la stima del bisogno sanitario;
- 1 indicatore di equità sociale;
- 10 indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA).

All'interno del NSG è stato individuato un sottoinsieme di 22 indicatori cosiddetto «CORE» (Tabella 7.12), distribuito sulle aree «Prevenzione collettiva e sanità pubblica», «Assistenza Distrettuale» e «Assistenza Ospedaliera», da utilizzare a regime per valutare sinteticamente l'erogazione dei LEA e il conseguente accesso alla quota integrativa del FSN da parte delle Regioni.

In discontinuità rispetto alla vecchia griglia LEA, dove il punteggio per ciascuna regione veniva calcolato in forma aggregata per i diversi macro-livelli sottoposti a monitoraggio, con il nuovo sistema i punteggi dei livelli di prevenzione, assistenza ospedaliera e distrettuale/territoriale vengono riportati in forma separata, ciascuno su una scala normalizzata da 0 a 100, e calcolati come una media pesata dei punteggi degli indicatori per ciascun macro-livello. La soglia minima ai fini della «sufficienza» in ciascun livello è stabilita al 60% (mentre per la griglia LEA, il punteggio totale minimo per essere considerati adempienti era 160, corrispondente a circa il 70% del punteggio massimo ottenibile). Analizzando i risultati sperimentali fatti registrare dalle singole regioni sulle singole aree identificate dal NSG, emerge un quadro sostanzialmente confortante, almeno rispetto alla soglia di sufficienza impiegata come metrica per la valutazione del livello quali-quantitativo di erogazione dei LEA, sebbene non manchino spazi importanti di miglioramento. In sintesi, a dati 2023 (Tabella 7.13):

- Nessuna regione registra in tutte le aree valori al di sotto della soglia di «sufficienza».
- Otto regioni (Valle d'Aosta, P.A. Bolzano, Liguria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) figurano come «non adempienti», presentando almeno un'area il cui punteggio si attesta sotto la soglia dei 60 punti.
- Si riduce, rispetto al 2022, il numero di regioni con punteggi contenuti sul fronte della prevenzione. Sono 5 a dati 2023 (P.A. Bolzano, Liguria, Abruzzo, Molise e Sicilia), contro le 7 del 2022.
- L'unica regione a registrare difficoltà nell'area ospedaliera è la Valle D'Aosta.
- L'area distrettuale registra criticità in Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia, oltre alla già citata Valle d'Aosta.

Analizzando l'andamento nel tempo delle tre macro-aree oggetto di sperimentazione, le Figure che seguono rappresentano il confronto tra il periodo pre-

Tabella 7.12 **Indicatori «core» del Nuovo Sistema di Garanzia per area di monitoraggio**

Area prevenzione	Area distrettuale	Area ospedaliera
P01C – Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	D03C* - Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (≥ 18 anni) per: complicanze (a b/l termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco	H01Z – Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato in rapporto alla popolazione residente
P02C – Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	D04C* - Tasso di ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite	H02Z – Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui
P10Z – Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino	D09Z - Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	H04Z – Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (Allegato B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario
P12Z – Copertura delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale	D10Z - Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B	H05Z – Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni
P14C – Indicatore composito stili di vita	D14C - Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti. Antibiotici	H13C - Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giorni in regime ordinario
P15C – Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cervice uterina, colon e mammella	D22Z - Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1, CIA2, CIA 3)	H17C – Percentuale parti cesarei primari in maternità di I livello o comunque con <1.000 parti
	D27C - Percentuale di ricoveri ripetuti tra 8 e 30 giorni in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche	H18C - Percentuale parti cesarei primari in maternità di II livello o comunque con ≥ 1.000 parti
	D30Z - Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore	
	D33Za - Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente, per tipologia di trattamento (intensità di cura)	

* Indicatori D03C e D04C da inserire nel CORE ad anni alterni. Per l'anno 2023 è stato inserito nel CORE l'indicatore D04C

Tabella 7.13 **Applicazione indicatori CORE-NSG: sintesi 2023**

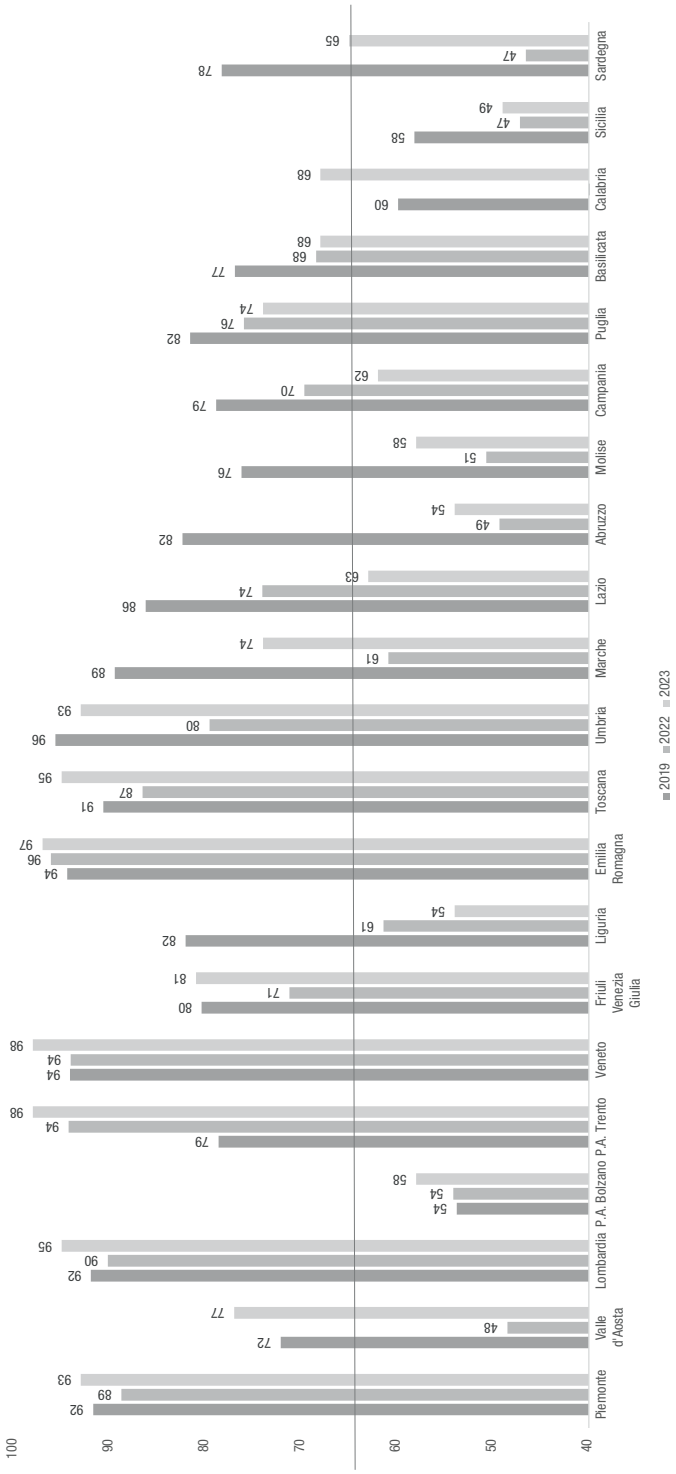
Regioni	Area Prevenzione	Area Distrettuale	Area Ospedaliera	"Adempienza"
Piemonte	93	90	87	✓
Valle d'Aosta	77	**35**	**53**	✗
Lombardia	95	76	86	✓
P.A. Bolzano	**58**	82	62	✗
P.A. Trento	98	83	97	✓
Veneto	98	96	94	✓
Friuli Venezia Giulia	81	81	73	✓
Liguria	**54**	85	80	✗
Emilia Romagna	97	89	92	✓
Toscana	95	95	96	✓
Umbria	93	80	84	✓
Marche	74	83	91	✓
Lazio	63	68	85	✓
Abruzzo	**54**	**45**	83	✗
Molise	**58**	73	62	✗
Campania	62	72	72	✓
Puglia	74	69	85	✓
Basilicata	68	**52**	69	✗
Calabria	68	**40**	69	✗
Sicilia	**49**	**44**	80	✗
Sardegna	65	67	60	✓

Fonte: Ministero della Salute – Nuovo Sistema di Garanzia (2025)

pandemico e le ultime due annualità della rilevazione di cui si dispone (2019 e 2022-2023). Con riferimento alla prima area si osserva un miglioramento generalizzato rispetto al 2022, con 16 regioni che presentano punteggi superiore all'anno precedente. Allo stesso tempo, i dati rilevati sul 2022 avevano fatto registrare un generalizzato peggioramento, anche consistente in 10 regioni (superiore al 10%), rispetto all'anno precedente. Difficilmente valori così altalenanti possono essere riconducibili alla mera gestione degli SSR, bensì aprono ad alcune riflessioni di fondo rispetto alla bontà dello strumento, alla sua capacità di intercettare fenomeni prioritari per il SSR e alle modalità con cui viene alimentato Nel caso dell'area distrettuale, si osserva una situazione più variegata, similmente a quanto osservato nel 2022: in 12 contesti regionali si registra un peggioramento dei punteggi rispetto all'osservazione precedente, nelle restanti un miglioramento. I differenziali tra un anno e l'altro vanno dal -27,9% dell'Abruzzo al +32,8% della Sardegna. Anche in questo caso si tratta di oscillazioni rilevanti, in archi temporali eccessivamente ristretti per essere imputabili solo alla mera gestione dei servizi nei singoli sistemi regionali. Nell'area ospedaliera, infine, si osserva un quadro di diffuso peggioramento rispetto al 2022, ma con una variabilità più contenuta rispetto alle altre due dimensioni considerate.

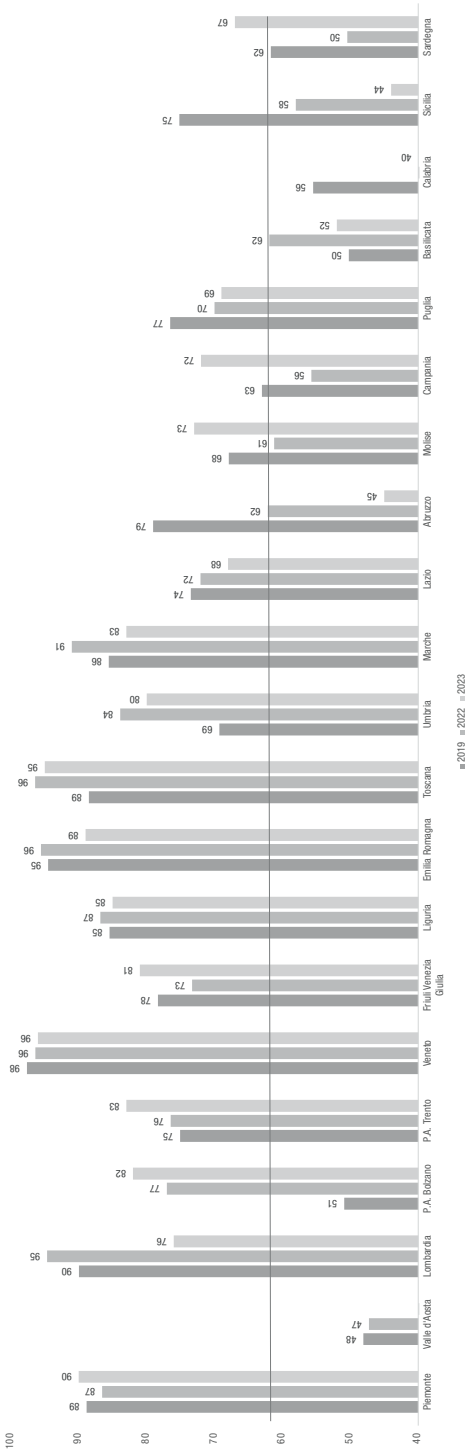
Al NSG, come è noto, il livello centrale ha recentemente accostato due nuo-

Figura 7.7 **Indicatori CORE-NSG: area prevenzione, 2019, 2022, 2023**



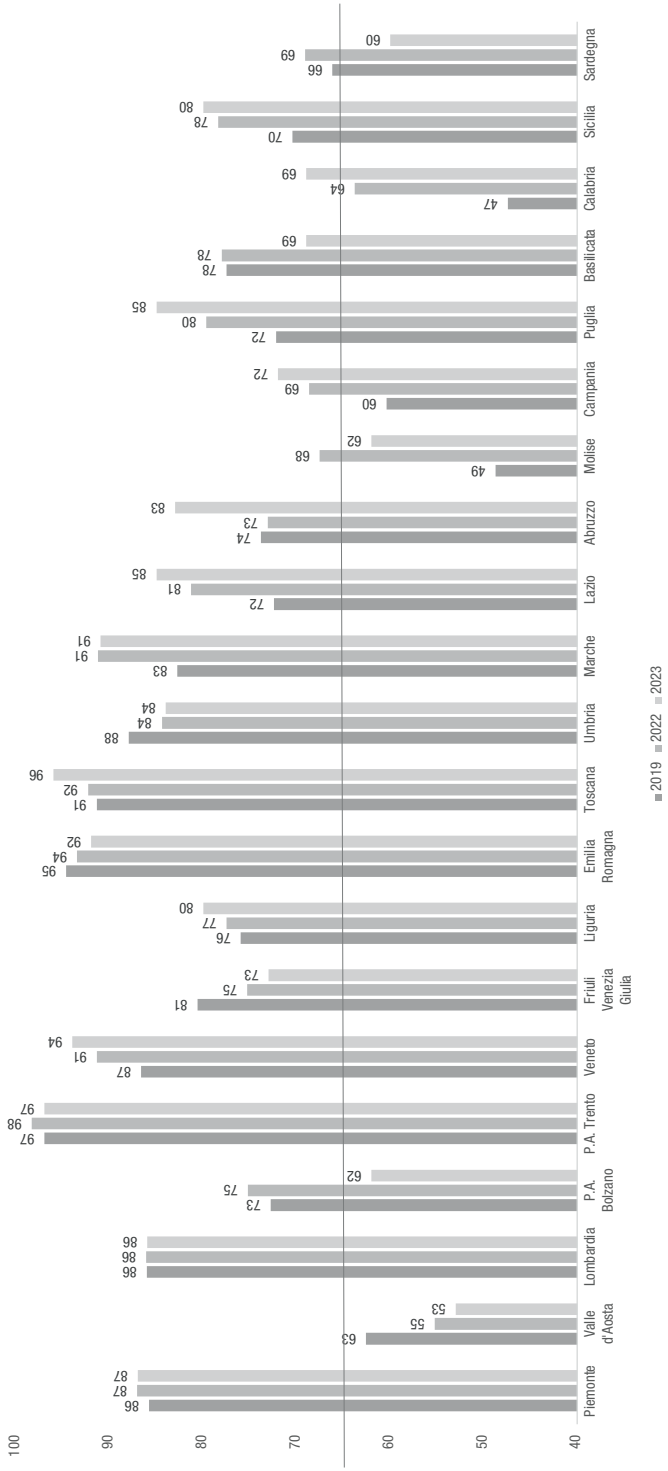
Fonte: Rielaborazione degli autori su dati Ministero della Salute - Nuovo Sistema di Garanzia (2025)

Figura 7.8 **Indicatori CORE-NSG: area distrettuale, andamento 2019, 2022, 2023**



Fonte: Rielaborazione degli autori su dati Ministero della Salute - Nuovo Sistema di Garanzia (2025)

Figura 7.9 **Indicatori CORE-NSG: area ospedaliera, andamento 2019, 2022, 2023**



Fonte: Rielaborazione degli autori su dati Ministero della Salute - Nuovo Sistema di Garanzia (2025)

vi strumenti di monitoraggio. Si tratta dei *Modelli di Valutazione delle Performance* rispettivamente delle *Aziende Ospedaliere* (2023 e successive modifiche) e *Territoriali* (2024). Nel disegnare i due strumenti sono stati considerati alcuni ambiti di analisi tradizionali, altri con un potenziale slancio innovativo. Per quanto riguarda le AO[4], sono state definite 4 aree di performance (Accessibilità, Governance dei Processi Sanitari, Sostenibilità economico-finanziaria e Investimenti), 10 sub-aree, a loro volta declinate in 27 indicatori (Tabella 7.14)

Tabella 7.14 **Aree, sub-aree e indicatori individuati dal «Modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale nelle Aziende Ospedaliere» di AGENAS**

Aree	Sub-aree	Indicatori
Accessibilità	Tempi di attesa	Protesi d'anca entro 180 giorni
		Tumore mammella entro 30 giorni
		Tumore colon entro 30 giorni
		Tumore polmone entro 30 giorni
		Tumore prostata entro 30 giorni
	Pronto soccorso	Permanenza in PS oltre 48h
		Abbandoni del PS
Governance processi organizzativi	Appropriatezza	Ricoveri ad alto rischio appropriatezza
		DH diagnostici su DH medici
		Dimissioni DRG medici da reparti chirurgici
	Efficienza	Interventi per sala operatorial
		Degenza media pre-operatoria
		Indice comparativo di performance (ICP)
	Attrattività	Mobilità attiva alta complessità
		Mobilità attiva interventi oncologici
Sostenibilità economico patrimoniale	Costi operativi	Costo risorse umane
		Consumo farmaci
		Consumo dispositivi medici
		Costo servizi appaltati
		Costo giornata di degenza
	Gestione magazzino	Rotazione magazzino farmaci
		Rotazione magazzino dispositivi medici**
	Tempestività pagamenti	Indicatore tempestività pagamenti
Investimenti	Stato del patrimonio	Obsolescenza contabile
		Vetustà grandi apparecchiature
	Rinnovo tecnologico	Incremento immobilizzazioni materiali
		Ricorso a noleggio/leasing

* Non incluso in valutazione

Nota: non è rappresentata in tabella la dimensione del "Personale", che rappresenta una sezione a sé stante del portale statistico AGENAS.

Fonte: AGENAS (2024)

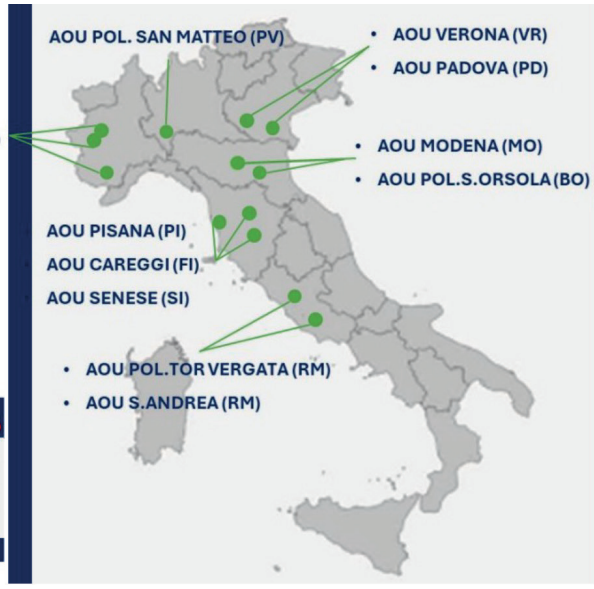
[4] Sono incluse nel raggruppamento considerato da AGENAS anche le Aziende Ospedaliero-Universitarie (AOU).

con una buona corrispondenza rispetto ai macro-obiettivi che le regioni attribuiscono alle direzioni generali aziendali (si veda il paragrafo 7.4.2). Questa struttura "a matrioska" è stata applicata in relazione a quattro cluster di aziende, identificati incrociando dimensionamento (numero posti letto) e natura giuridica (AO vs AOU) utilizzando i dati 2023.

La Figura 7.10 offre la rappresentazione di sintesi proposta da AGENAS (2024): nel 2023 sono 13 (25%) le AO/AOU che rispondono a quello che il modello definisce come un elevato livello complessivo di «performance», in aumento rispetto alla rilevazione 2021, quando erano 9. Queste Aziende operano nelle regioni settentrionali e centrali del Paese, sono nella quasi totalità AOU (11 su 13) e sono quasi simmetricamente distribuite tra le due classi dimensionali (in 7 casi sono Aziende con più di 700 PL, in 6 casi hanno meno di 700 PL).

Per quanto riguarda le Aziende Territoriali così come definite da AGENAS, sono state definite 6 aree di performance (Prevenzione, Assistenza Distrettuale, Assistenza Ospedaliera, Sostenibilità economico-finanziaria, Investimenti e Outcome), 12 sub-aree, a loro volta declinate in 34 misure (Tabella 7.15). Anche in questo caso, le aziende sono state organizzate in quattro raggruppamenti definiti dal bacino di utenza di riferimento. La Figura 7.11 offre la rappre-

Figura 7.10 **Rappresentazione di sintesi AGENAS del «Modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale nelle Aziende Ospedaliere» (dati 2023)**



Punteggio a 3 livelli

Tipologia di Azienda	Livello di Performance Alto	Medio	Basso
AOU > 700 posti letto	7	10	3
AOU < 700 posti letto	4	3	3
AO > 700 posti letto	0	5	2
AO < 700 posti letto	2	7	5
Totale	13	25	13

Fonte: AGENAS (2024)

Tabella 7.15 **Aree, sub-aree e indicatori individuati dal «Modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale nelle Aziende Territoriali» di AGENAS**

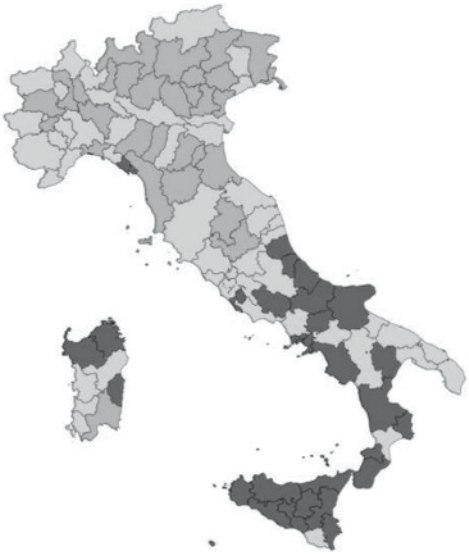
Aree	Sub-aree	Indicatori
Prevenzione	Screening	Screening mammella
		Screening cervice
		Screening colon
Assistenza distrettuale	Cure primarie	Assistiti adulti (scelte) per MMG
		Assistiti pediatrici (scelte) per PLS
		Contatti per MCA
	Dotazione servizi territoriali	Posti letto in Hospice
		Consultori familiari
		Posti letto in strutture residenziali
	Presa in carico territorio	Assistiti over 65 in assistenza domiciliare
		Assistiti in trattamento sanitario residenziale
		Allarme target
		Assistiti da dipartimenti salute mentale
		Accessi in PS evitabili over 75
	Consumo prestazioni specialistiche	Consumo pro-capite di prestazione eco addome
		Consumo pro-capite di prestazioni di laboratorio
		Consumo pro-capite di prestazioni di RM osteoarticolari in pz > 65anni
	Ospedalizzazioni evitabili	Ospedalizzazioni per complicanze diabete
		Ospedalizzazioni per BPCO
		Ospedalizzazioni per scompenso cardiaco
Assistenza ospedaliera	Attività dei presidi ospedalieri	Rispetto tempi attesa interventi chirurgici
		Degenza media medicina interna e geriatria
		Indice di fuga medio-bassa complessità
Sostenibilità economico-patrimoniale	Costi pro-capite	Costo totale dell'assistenza pro-capite
		Costo prevenzione pro-capite
		Costo medicina di base pro-capite
		Costo farmaceutica convenzionata pro-capite
	Tempestività dei pagamenti	Indicatore tempestività pagamenti
Investimenti	Stato del patrimonio	Obsolescenza contabile
		Vetustà grandi apparecchiature
	Rinnovo tecnologico	Incremento immobilizzazioni materiali
		Ricorso a noleggio/leasing
Outcome	Mortalità evitabile	Mortalità trattabile
		Mortalità prevenibile

Fonte: AGENAS (2024)

sentazione di sintesi proposta da AGENAS (2024): nel 2023 sono 27 (24,5%) le Aziende che rispondono a quello che il modello definisce come un elevato livello complessivo di «performance». Sono Aziende che operano tipicamente nelle regioni settentrionali e centrali del Paese, con una rappresentanza diffusa di tutti i raggruppamenti per bacino d'utenza.

Figura 7.11 **Rappresentazione di sintesi AGENAS del «Modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale nelle Aziende Territoriali» (dati 2023)**

CLUSTER	Basso	Medio	Alto
<250.000 ab	7	17	3
250.000-400.000 ab	7	15	6
400.000-700.000 ab	8	9	11
> 700.000 ab	5	12	10
TOTALE	27	53	30



Fonte: AGENAS (2024)

7.4.2 Le ricadute sugli obiettivi delle direzioni generali aziendali

Nel raccordo istituzionale è fisiologico che l'impiego di sistemi di monitoraggio e valutazione a livello nazionale, con annesso sblocco della quota premiale del FSN, abbia delle ricadute sulle modalità di rappresentazione delle priorità, e della loro declinazione, dei livelli regionale e aziendale. A questo proposito, è dunque interessante approfondire le prassi, quantomeno istituzionali, con cui le regioni tendono a incorporare macro-aree e metriche del NSG nei sistemi operativi regionali e aziendali. Nel proporre questo tipo di riflessione, la Tabella 7.11 mostra innanzitutto una sintesi di alcune Delibere regionali di assegnazione degli obiettivi alle direzioni strategiche delle aziende sanitarie pubbliche[5]. Nello specifico sono state analizzate le Delibere regionali di 5 SSR: Piemonte,

[5] Il contenuto della Tabella è frutto di una rielaborazione concettuale da parte degli autori. Per tale motivo potrebbe non esserci perfetto allineamento tra il contenuto rappresentato nei documenti istituzionali consultati e la classificazione qui proposta. A titolo esemplificativo, la Sicilia fa riferimento nella propria DGR alla categoria "esiti" proponendo come contenuti della sezione le prestazioni sentinella ex DM 70/2015 (per approfondimenti si veda Ardito et al, 2022), confluita nella Tabella 7.11 nella famiglia degli obiettivi relativi a "Appropriatezza organizzativa, qualità ed equità dell'assistenza" per garantire coerenza interpretativa con gli altri SSR analizzati.

Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia. Questo tipo di rappresentazione è utile per fotografare gli oggetti considerati prioritari per i diversi SSR e la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi. A questa considerazione se ne aggiungono almeno altre tre: (i) se e in che termini sono attivati processi qualitativi/discrezionali di valutazione dell'operato delle direzioni; (ii) la presenza di eventuali strategie di concentrazione (numero limitato di dimensioni presidiate e alto peso specifico di ciascuna) e/o frammentazione (tante dimensioni presidiate e peso specifico di ciascuna modesto) del meccanismo di identificazione formale delle priorità degli SSR; (iii) il grado di personalizzazione previsto per le singole aziende dei diversi SSR, tenendo conto della tipologia di azienda (es. azienda di produzione vs azienda territoriale) e/o delle specificità ambientali e del modello di offerta della singola azienda nell'attribuzione dei pesi.

In sintesi, seguendo l'ordine di rappresentazione appena rappresentato, è possibile evidenziare come:

- Sono 17 i macro-obiettivi in capo alle direzioni strategiche formalmente presenti negli atti di programmazione degli SSR considerati, con una media di circa 9,5 aree per ciascun SSR.
- I singoli macro-obiettivi sono mediamente presenti in 4 SSR sui 5 analizzati, con una maggiore convergenza rispetto alla rilevazione 2024. Quelli presenti in tutti gli SSR sono rappresentati da «Assistenza territoriale», «Tempi d'attesa e governo delle liste»; «Prevenzione e sanità pubblica»; «Pronto Soccorso ed Emergenza-Urgenza»; «Veterinaria», «Gestione delle risorse umane e valorizzazione del personale», «Recupero mobilità» e «Percorsi di certificabilità dei bilanci» sono al contrario esplicitati con una sezione dedicata solo in uno degli SSR.
- L'Emilia Romagna si conferma l'unica Regione in cui non vengono espressamente attribuiti i pesi specifici alle dimensioni di valutazione delle direzioni aziendali. In questo SSR, infatti, il peso specifico di ciascuna dimensione è tarato sulle specificità espresse dalle singole aziende e sulla base del contesto socio-economico in cui esse operano.
- In Lombardia, a integrazione delle percentuali assegnate ai macro-obiettivi rappresentati in Tabella (70% del peso complessivo), la valutazione delle direzioni aziendali è accompagnata da una componente più discrezionale caratterizzata dai «*punteggi indicati da un Comitato ristretto di Assessori (Presidente, Assessore al Welfare, Assessore al Bilancio e Finanza) sulla base di una valutazione sulla qualità/comportamenti manageriali e dalla presenza di un monitoraggio discrezionale*» (30% del peso complessivo).
- Al netto di «Tempi d'attesa e governo delle liste» e «Governo dei fattori produttivi», che presentano pesi specifici diffusamente elevati e almeno pari a 10, non emergono altre aree di responsabilizzazione che registrino valori medi significativi.

Tabella 7.16 **La rappresentazione formale degli obiettivi delle direzioni strategiche aziendali: macro-obiettivi e relativi pesi, 2025 o ultimo anno disponibile**

Macro-obiettivi	Piemonte	Lombardia			Emilia Romagna	Lazio			Sicilia	
	ASL/AO/AOU	ATS	ASST	ASST Niguarda e Valtellina		ASL	AO/AOU/ IRCCS	ARES	ASP	AO/AOU
Economico-finanziario e governo dei fattori produttivi	14				b	17	41	70		
Appropriatezza organizzativa, qualità, rischio clinico ed equità dell'assistenza	12			7	b	6	2		21	24
Area veterinaria		3								
Assistenza ospedaliera	2	4	5	5	b			23	8	18
Assistenza territoriale	8	10	10	9	b	7			12	12
Tempi di attesa e governo delle liste	6	12	12	10	b	20	23		10	10
Donazione organi e tessuti	2								5	9
Attuazione PNRR (M6 Salute)						22	16	6		
Miglioramento Pronto Soccorso e percorsi di emergenza-urgenza	8	2	4	4	b	10	13		4	8
Farmaceutica e dispositivi medici	6	5	5	4	b				5	5
Patrimonio edilizio e innovazione tecnologica	8	7	7	7		6	5	1	8	8
Percorso di certificabilità e trasparenza									3	3
Prevenzione e sanità pubblica	12	8	5	5	b	12			24	3
Adempimenti amministrativi e digitalizzazione	8	7	7	7	b					
Monitoraggio e garanzie LEA / NSG	4	12	15	12						
Gestione delle risorse umane e valorizzazione del personale	4									
Recupero della mobilità passiva	6									
Totale	**100**	**70**	**70**	**70**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Fonte: elaborazione degli autori su delibere di assegnazione degli obiettivi regionali alle direzioni aziendali. Nello specifico si riportano di seguito i documenti consultati: la DGR 16-817 del 2025 di Regione Piemonte; la Deliberazione XII/3771 del 2025 di Regione Lombardia; la DGR 972/2025 della Regione Emilia Romagna; la Deliberazione 363/2025 del Lazio; la DGR 195/2024 della Regione Siciliana con programmazione sul triennio.

07_Oasi.indd 38 02/12/25 15:58

Queste evidenze segnalano come i diversi SSR si diano ambiti di intervento prioritario differenziati nel confronto interregionale e di come la maggior parte di essi tenda a parcellizzare gli obiettivi, presidiando un numero elevato di dimensioni a cui sono attribuiti pesi relativi modesti. Emergono sotto questo profilo almeno quattro modi di interpretare l'autonomia decisionale nell'indirizzare l'operato e le scelte delle direzioni aziendali: (i) chi predilige individuare poche aree di risultato attribuendo pesi specifici mediamente significativi (Lazio); (ii) chi identifica due-tre macro-obiettivi *flagship* a cui attribuisce pesi specifici significativi (Piemonte, Lombardia); (ii) chi identifica i macro-obiettivi customizzando l'importanza relativa da attribuire a ciascuno sulla base dei contributi attesi (diversificati) dalle singole aziende nel conseguimento degli obiettivi regionali (Emilia Romagna); (iv) chi diluisce presidiando più macro-obiettivi con pesi specifici mediamente non elevati (Sicilia). In generale, eccezione fatta per l'Emilia Romagna, permane la tendenza a non personalizzare gli obiettivi da attribuire alle singole direzioni aziendali, sebbene cresca il ricorso a differenziare quantomeno per tipologia di azienda (es. se azienda di erogazione o territoriale).

In continuità con le differenti soluzioni abbracciate dai singoli contesti regionali analizzati, anche l'inserimento più o meno marcato delle metriche del NSG è caratterizzato da una certa eterogeneità (evidenza non riportata in Tabella). Sotto il profilo della numerosità, gli SSR tendono a inserire l'intero panel di indicatori NSG-CORE o comunque una parte consistente. È raro osservare processi rielaborativi più selettivi. Sotto il profilo della modalità di rappresentazione, alcuni SSR (es. Piemonte) concentrano le metriche NSG-CORE all'interno di un'unica sub-area; altri (es. la Sicilia) abbinano le metriche all'area di riferimento del NSG («prevenzione», «territoriale/distrettuale», «ospedaliera»); altri ancora (es. Emilia Romagna) distribuiscono le metriche in corrispondenza del singolo macro-obiettivo di riferimento. Esistono dunque almeno tre diverse posture assunte dagli SSR: (i) SSR che attivano un monitoraggio ad hoc dell'intero NSG attraverso la creazione di una sub-area dedicata e conseguente responsabilizzazione «a cascata» e lineare del top management aziendale (es. Piemonte); (ii) SSR che diluiscono gli indicatori NSG nei diversi macro-obiettivi di riferimento, integrati ad altri indicatori e con un sistema di responsabilizzazione del top management delle singole aziende personalizzato sulla base delle specificità aziendali e di contesto (es. Emilia Romagna); (iii) SSR più selettivi nella scelte delle metriche NSG-CORE da far confluire nel processo di responsabilizzazione del top management aziendale, con un monitoraggio parallelo del ciclo di programmazione e controllo sui risultati del sistema NSG (es. Lazio). In ogni caso, è evidente come la scelta di architettura dello strumento definita dal livello centrale abbia una fisiologica influenza sulle scelte di prioritizzazione a livello regionale e aziendale. La sua impostazione per "verticali" e l'anacronismo in molte delle scelte di misurazione proposte

(es. la modesta presenza o assenza di aree di monitoraggio dedicate a consumi e/o processi) rischiano tuttavia di produrre degli effetti distorti sull'orientamento delle convenienze per gli attori di sistema e sul loro effettivo comportamento, oltre che disancorare il sistema di misurazione dai reali fabbisogni informativi utili a sostenere il funzionamento aziendale.

7.5 Discussione e conclusioni

Come in ogni edizione del Rapporto OASI, all'interno di questo capitolo si rappresentano alcune misure di esito di salute per il nostro Paese e si discutono i principali strumenti di monitoraggio e/o di "valutazione" del SSN in base ai dati più aggiornati disponibili. La prima parte del capitolo ha proposto alcune riflessioni su livelli di equità e risultati di salute generati dal SSN. La seconda ha approfondito le modalità con cui il SSN rappresenta formalmente obiettivi e risultati conseguiti.

Sotto il primo profilo, l'Italia fa registrare una delle aspettative di vita alla nascita più elevate a livello internazionale, con una media di 83,5 anni, inferiore solo a Svizzera, Giappone e Spagna. La mortalità continua a essere in larga parte dovuta a malattie del sistema cardiocircolatorio (219,3 per 100.000 abitanti) e tumori (196,3 per 100.000 abitanti). Entrambi i valori registrano una costante e strutturale riduzione nelle ultime rilevazioni, oltre a essere inferiori alla media registrata tra i principali Paesi OCSE selezionati per l'analisi. A livello nazionale, i dati ISTAT mostrano nel 2023 un'aspettativa di vita inferiore di circa 1,5 anni in meno al Sud (82,1) rispetto al Nord e al Centro (rispettivamente 83,6 e 83,4) e una speranza di vita a 65 anni di circa 20,9 anni, con differenze più contenute tra le tre aree geografiche. La speranza di vita in buona salute alla nascita nel 2023 è in ulteriore peggioramento rispetto agli scorsi anni con un dato nazionale di 58,1 anni (passando dai 69,7 anni della P.A. di Bolzano ai 53,4 anni della Calabria). Il differenziale tra aspettativa di vita alla nascita generale e in buona salute è in media pari a 24,9 anni, in aumento di un anno e mezzo rispetto alla precedente rilevazione. Anche in questo caso sono rilevanti le differenze interregionali osservate, a cui si collega una significativa eterogeneità di prevalenza delle cronicità, ancorate a differenze perlopiù di matrice socio-economica e accompagnate da tassi di aderenza terapeutica nel complesso modeste e migliorabili.

Guardando al secondo aspetto, dai dati 2023 del Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dei LEA emerge come otto regioni (Valle d'Aosta, P.A. Bolzano, Liguria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia) risulterebbero «non adempienti», ossia con un punteggio inferiore alle soglie previste in almeno una delle tre macro-aree (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera). Tuttavia, emerge chiaramente come le rilevazioni degli ultimi anni producano a parità di altre condizioni

delle differenze significative, non necessariamente imputabili all'azione di regioni e aziende. Difficilmente i valori altalenanti osservati possono essere riconducibili alla mera gestione degli SSR. Piuttosto, sembra che il NSG fatichi a cogliere e rappresentare adeguatamente le specificità del SSN, generando un disallineamento tra ciò che potrebbe essere auspicabile misurare (es. processi, consumi per sotto-popolazioni, outcome) e il modo in cui le misure vengono effettivamente definite e costruite (produzione, output). Ne sono esempio emblematico l'organizzazione per verticali tra loro chiaramente interdipendenti (prevenzione vs area distrettuale vs area ospedaliera) e le metriche impiegate, che tendono a privilegiare a larghi tratti logiche di produzione che rischiano di offrire letture parziali e talvolta distorsive. Esistono dunque alcuni spazi importanti di riflessione rispetto alla bontà dello strumento e alla sua capacità di intercettare fenomeni prioritari per il sistema sanitario.

L'utilizzo di strumenti di valutazione di questo tipo ha infatti l'indubbio vantaggio di porre enfasi sulla definizione di logiche di benchmark che possono contribuire a confrontare l'andamento degli SSR e di farlo adottando approcci *evidence-based* che imprimano ulteriore spinta allo sviluppo della cultura del dato come fattore per ridurre la discrezionalità di alcuni elementi decisionali. Allo stesso tempo, questi strumenti hanno potenzialmente il vantaggio di orientare il comportamento degli attori in gioco, ad esempio attraverso l'incorporazione nei sistemi operativi regionali e aziendali. È tuttavia necessario prestare attenzione alla capacità dei sistemi di misurazione di esprimere caratteristiche utili rispetto ai fenomeni che cercano di descrivere e dotarsi di adeguati flussi informativi, ad oggi non sempre solidi e tempestivi. Infatti, interpretare la multidimensionalità sotto il mero profilo degli input (o al massimo output) di sistema, tenendo fuori aspetti legati ad outcome clinici o funzionali e/o collegati al governo dei consumi, riduce la possibilità di proporre riflessioni più approfondite e strutturate sul collegamento tra dimensioni e cicli programmatori di risorse, processi e risultati. Queste considerazioni acquisiscono valore considerando quanto i diversi SSR incorporino le metriche NSG nei processi di responsabilizzazione delle direzioni aziendali. Ci sono ad esempio contesti che attivano un monitoraggio ad hoc dell'intero NSG attraverso la creazione di una sub-area di monitoraggio dedicata e conseguente responsabilizzazione «a cascata» e lineare del top management aziendale. In altri casi, invece, si preferisce collocare gli indicatori NSG nei macro-obiettivi strategici di riferimento, integrandoli ad altre metriche e con un sistema di responsabilizzazione del top management delle singole aziende personalizzato sulla base delle specificità aziendali e di contesto. Più raramente, si registra una certa selettività nella scelta delle metriche NSG da far confluire nel processo di responsabilizzazione del top management aziendale. In generale, si registra una diffusa tendenza alla parcellizzazione degli obiettivi attraverso il presidio di un numero elevato di dimensioni con pesi relativi modesti, senza tenere in eccessiva considerazione

la diversa tipologia di azienda cui questi si rivolgono (es. ASL vs AO) e la loro contestualizzazione nel tempo e nello spazio. La presenza di queste metriche sul livello regionale è chiaramente pervasiva, con conseguenze non trascurabili, sia sull'azione manageriale e sulla sua autonomia, che generano forme di estroflessione potenzialmente limitanti la dinamicità e la capacità innovativa proveniente "dal basso". In altri termini, il rischio reale e osservabile è che i fabbisogni informativi esterni prevalgano sulle esigenze gestionali interne, congelando o atrofizzando le spinte innovative che le aziende producono e i sistemi operativi che possono rappresentarle.

Guardando poi ai modelli di rappresentazione delle performance aziendali promossi da AGENAS, essi mirerebbero, da un lato, a guardare all'efficacia dell'azione manageriale nel perseguire i fini istituzionali; dall'altro, a stimolare l'attivazione di circoli virtuosi di mutuo apprendimento e convergenza di posizionamento delle aziende attraverso l'applicazione di logiche di benchmarking. In questa prospettiva ciascuno degli strumenti proposti è caratterizzato da diverse dimensioni rilevanti, che in linea di principio possono rappresentare un interessante punto di partenza nel sostenere quel collegamento tra risorse, processi e risultati essenziale per determinare efficacia e valore prodotto nell'erogazione dei servizi. In maniera meno nitida, essi tuttavia non esplicitano se la direzione sia quella di valutare ex-post l'operato dei nodi della rete erogativa o quanto invece il fine sia supportare la programmazione sanitaria nazionale. Invece di attivare piattaforme di dialogo e confronto, rischiano nella pratica di produrre una tensione significativa sull'esposizione della singola azienda rispetto alla propria "posizione", di fatto acuendo comportamenti difensivi e/o competitivi e distruggendo preventivamente potenziale valore generabile dalla complementarietà di un'azione di rete congiunta e integrata. Spostando l'attenzione sul loro design, lo sviluppo su diversi livelli dei modelli proposti è apprezzabile, così come la scelta di disarticolare le aree di performance in sub-aree ad ampio spettro, sebbene coprendo dimensioni «tradizionali» (es. appropriatezza, qualità, aspetti economico-finanziari, tempi d'attesa e PS, personale, investimenti). La scelta delle metriche sconta tuttavia alcuni aspetti potenzialmente critici legati a (i) capacità di esprimere il fenomeno che mira a descrivere (es. indicatori su investimenti legati a poste patrimoniali e non orientati ai benefici indotti dalla loro realizzazione), (ii) processi di responsabilizzazione integrati (di filiera e/o tra partizioni organizzative all'interno delle aziende), (iii) oggetti di rilevazione «classici» e poco orientati a processi e pazienti. Attenzione, quindi, ai rischi connessi all'impiego di simili strumenti e ai processi collegati che, se non adeguatamente gestiti, possono condurre all'attivazione di meccanismi distorsivi. Tra questi, ad esempio:

- il fatto di porre enfasi su aree di risultato e metriche individuate per lo sviluppo del modello può ridurre l'attenzione su altri elementi rilevanti, anche

nei medesimi spettri di valutazione (si pensi ad esempio al rischio di attribuire minore importanza relativa al monitoraggio dei tempi d'attesa legati a prestazioni diverse da quelle monitorate o, soprattutto, alle modalità con cui la misura viene rilevata);
- interpretare la multidimensionalità sotto il mero profilo degli input (o al massimo output) di sistema, tenendo fuori aspetti legati all'esperienza del paziente e agli outcome clinici o funzionali, riduce la possibilità di proporre riflessioni più approfondite e strutturate sul collegamento tra dimensioni e cicli programmatori di risorse, processi, risultati;
- la poca enfasi sulla generazione di valore prodotto dalle aziende sia in termini di servizi erogati che di benefici più generali prodotti sul contesto di riferimento, senza peraltro differenziare il sistema di attese e di bisogno in cui la singola azienda opera, rischia di comprimere l'efficacia della rendicontazione agli stakeholder depotenziando i collegati e potenziali processi di accountability;
- promuovere ulteriore disallineamento tra fabbisogni esterni ai contesti aziendali e oggetti di analisi e misure funzionali ai processi decisionali interni può indurre a ridurre le spinte al cambiamento di pratiche e tool manageriali.

L'implicito di ogni sistema di misurazione è che la soggettività a monte delle scelte strategiche rappresenti la base su cui costruire i meccanismi di monitoraggio e orientamento dei comportamenti di sotto-gruppi e individui. In un sistema a universalismo dichiarato questo aspetto può implicare la creazione di narrazioni false sulle possibilità di offrire tutto a tutti, specialmente laddove le risorse sono scarse e la capacità di settare le attese contenute. I dati di realtà suggeriscono l'esistenza di un universalismo selettivo implicito, che nei fatti suggerisce di superare tale prassi e richiede di proporre logiche di prioritizzazione mature a cui accompagnare metriche davvero utili a rappresentare e accompagnare i meccanismi di funzionamento del SSN e la sua sostenibilità.

7.6 Bibliografia

AIFA (2023), Rapporto OsMed 2023. Disponibile online: https://www.aifa.gov.it/-/l-uso-dei-farmaci-in-italia-rapporto-osmed-2023.

Ardito V., Benetti L., Ciani O., Federici C. B., Furnari A., Tarricone R. Esiti di salute e performance del Servizio Sanitario Nazionale in Rapporto OASI 2023 CERGAS (a cura di), Egea, chap. 7, pp.267-316, 2023.

Boscolo P., Ciani O., Federici C., Furnari A., Tarricone R. (2017), «Gli esiti di salute del Servizio Sanitario Nazionale» in CERGAS (a cura di), Rapporto OASI 2017, Milano, EGEA.

Choi AI, Weekley CC, Chen SC, Li S, Kurella Tamura M, Norris KC, Shlipak MG. Association of educational attainment with chronic disease and mortality: the Kidney Early Evaluation Program (KEEP). Am J Kidney Dis. 2011 Aug;58(2):228-34. doi: 10.1053/j.ajkd.2011.02.388. Epub 2011 May 20. PMID: 21601328; PMCID: PMC3144262.

Crialesi R., Gargiulo L., Iannucci L. (2014), presentazione «L'indagine Istat sulle condizioni di salute ed il ricorso ai servizi sanitari», disponibile online: http://www.ceistorvergata.it/public/CEIS/file/press/L%E2%80%99indagine%20Istat%20sulle%20condizioni%20di%20salute%20ed%20il%20ricorso%20ai%20servizi%20sanitari.pdf.

Global Burden of Disease 2019 Cancer Collaboration. Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life Years for 29 Cancer Groups From 2010 to 2019: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. JAMA Oncol. 2022;8(3):420–444. doi:10.1001/jamaoncol.2021.6987.

ISS (2025), Sistema di monitoraggio PASSI. Dati disponibili online: https://www.epicentro.iss.it/passi/.

ISTAT (2023), Rapporto BES: Il benessere equo e sostenibile in Italia, 2023. Roma, ISTAT.

ISTAT (2025), Indagine su decessi e cause di morte. Dati disponibili online: http://dati. istat.it/.

ISTAT (2025), Sistema di nowcast per indicatori demografici, dati disponibili online: http://dati.istat.it/ (sezione «Popolazione e famiglie», Indicatori demografici).

OECD (2020), «OECD Health Data», OECD Health Statistics database.

Oude Hengel K, Robroek SJW, Eekhout I, van der Beek AJ, Burdorf A. Educational inequalities in the impact of chronic diseases on exit from paid employment among older workers: a 7-year prospective study in the Netherlands. Occup Environ Med. 2019 Oct; 76(10):718–25.

Raghupathi, V., Raghupathi, W. The influence of education on health: an empirical assessment of OECD countries for the period 1995–2015. Arch Public Health 78, 20 (2020). https://doi.org/10.1186/s13690-020-00402-5.

WHO (2018). «World Health Statistics». Global Health Observatory database.